NURSING EDUCATIONAL SERIES



PATIENT SAFETY

A Comprehensive Nursing Guide — 6 International Patient Safety Goals

سلامة المريض

دليل شامل للممرضين — أهداف السلامة الدولية الست (IPSG)

> *"First, do no harm. Patient safety is not a choice — it is an obligation. Every nurse is a guardian of patient safety."*
>
> **— WHO (2021) • World Patient Safety Day**

RN, Ali Ashour, BSN

أخصائي عناية مركزة (ICU) — 6 سنين خبرة

Bachelor of Science in Nursing

★ BLS CERTIFIED ★

nursehub-egypt.vercel.app

© 2025 NurseHub Egypt — All Rights Reserved

PART 1 OF 5

Table of Contents — فهرس المحتويات

PART 1 — FOUNDATIONS — الأساسيات

01 Cover Page / الغلاف 01
02 Table of Contents / الفهرس 02
03 Learning Objectives / الأهداف 03
04 Quick Facts / حقائق سريعة 04
05 Evidence-Based Practice 05
06 Introduction & Definition 06

PART 2 — CORE CONCEPTS — المفاهيم

07 Importance of Patient Safety 07
08 Safety Culture / ثقافة السلامة 08
09 Medical Terminology (16 terms) 09
10 Swiss Cheese Model 10
11 6 IPSG Goals Overview ⭐ 11
12 IPSG 1: Patient Identification 12
13 IPSG 2: Effective Communication 13
14 IPSG 3: High-Alert Medications 14
15 IPSG 4: Correct Surgery (Time-Out) 15
16 IPSG 5: Infection Prevention (HAIs) 16
17 IPSG 6: Fall Risk Reduction 17

PART 3 — PROCEDURES — الإجراءات

18 Types of Medical Errors 18
19 Medication Safety (5 Rights) ⭐ 19
20 Incident Reporting / تقرير الحوادث 20
21 Root Cause Analysis (RCA) 21
22 SBAR Communication ⭐ 22
23 Handoff & Handover 23
24 Documentation Standards 24
25 Patient Rights / حقوق المريض 25
26 Informed Consent / الموافقة المستنيرة 26
27 ICU/ER Safety Considerations 27

PART 4 — CLINICAL SAFETY — السلامة السريرية

28 Common Mistakes ⭐ (أخطاء 10) 28
29 Red Flags / علامات الخطر 29
30 Pediatric & Elderly Safety 30
31 Pressure Injury Prevention 31
32 Restraint Safety / سلامة التقييد 32
33 Clinical Case Scenarios (حالات 4) 33
34 Clinical Pearls (لآلئ 10) 34
35 Compliance Monitoring 35

PART 5 — EXAM PREP — الامتحان

36 Cheat Sheet 36
37 OSCE Checklist ⭐ 37
38 OSCE Examiner Tips 38
39 Memory Mnemonics 39
40 MCQs Part 1 (Q1-Q5) 40
41 MCQs Part 2 (Q6-Q8) 41
42 True/False + Fill Blanks 42
43 AI Flashcards 43
44 NCLEX/Prometric Tips + FAQ 44
45 Key Takeaways + References 45
46 Back Cover / الغلاف الخلفي 46

Total: 46 pages ▪ 5 Parts ▪ Bilingual EN/AR Design v4.6 ▪ NurseHub Egypt © 2025

03 — Learning Objectives

الأهداف التعليمية

🎯 By the end of this guide, you will be able to: / بعد إنهاء هذا الدليل، ستكون قادراً على:

Goal: This module equips nursing students and practitioners with comprehensive knowledge about Patient Safety, the 6 International Patient Safety Goals (IPSG), error prevention, and evidence-based safety practices according to WHO, JCI, AHRQ, and IHI standards.

الهدف: يزوّد هذا الدليل طلاب التمريض والممارسين بمعرفة شاملة عن سلامة المريض، أهداف السلامة الدولية الست (IPSG)، منع الأخطاء، وممارسات السلامة المبنية على الأدلة وفقاً لمعايير WHO، JCI، AHRQ، وIHI.

- ✓ **Define** patient safety and its role in healthcare quality.
- ✓ **Explain** all 6 International Patient Safety Goals (IPSG).
- ✓ **Apply** the 5 Rights of Medication Administration.
- ✓ **Demonstrate** SBAR communication technique.
- ✓ **Identify** the Swiss Cheese Model of error causation.
- ✓ **Recognize** common medical errors and how to prevent them.
- ✓ **Perform** proper patient identification using 2 identifiers.
- ✓ **Conduct** a surgical safety checklist (Time-Out).
- ✓ **Evaluate** fall risk using validated assessment tools.

- ✓ **يُعرِّف** سلامة المريض ودورها في جودة الرعاية الصحية.
- ✓ **يشرح** أهداف السلامة الدولية الست (IPSG) بالكامل.
- ✓ **يطبق** الحقوق الخمسة لإعطاء الأدوية.
- ✓ **يوضح** تقنية التواصل SBAR عملياً.
- ✓ **يميز** نموذج الجبنة السويسرية لأسباب الأخطاء.
- ✓ **يكتشف** الأخطاء الطبية الشائعة وكيفية منعها.
- ✓ **يُنفذ** تعريف المريض الصحيح باستخدام مُعرِّفين.
- ✓ **يُجري** قائمة التحقق الجراحية (Time-Out).
- ✓ **يُقيِّم** خطر السقوط بأدوات تقييم معتمدة.

💡 Learning Tip: Patient safety is the #1 topic in NCLEX, Prometric, and JCI accreditation exams. Master it and you master nursing!

💡 نصيحة تعليمية: سلامة المريض هي الموضوع #1 في امتحانات NCLEX وPrometricg واعتماد JCI. اتقنها وتكون اتقنت التمريض!

Source: WHO (2021) Global Patient Safety Action Plan • JCI IPSG Standards • AHRQ PSNet.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

📊 Key Numbers Every Nurse Must Know / أرقام يجب على كل ممرض معرفتها

2.6M **Deaths/Year from Unsafe Care** وفيات سنوياً بسبب رعاية غير آمنة	**134M** **Adverse Events / Year (LMICs)** أحداث ضارة سنوياً (دول نامية)	**4 in 10** **Patients Harmed in Primary Care** مرضى يتأذون في الرعاية الأولية
80% **Errors Are Preventable** من الأخطاء يمكن منعها	**$42B** **Annual Cost of Unsafe Care** التكلفة السنوية للرعاية غير الآمنة	**3rd** **Leading Cause of Death (USA)** سبب رئيسي للوفاة في أمريكا

🔴 **Shocking Fact:** Medical errors are the **3rd leading cause of death** in the USA, after heart disease and cancer (Makary & Daniel, 2016, BMJ).

🔴 **حقيقة صادمة:** الأخطاء الطبية هي **ثالث سبب رئيسي للوفاة** في أمريكا، بعد أمراض القلب والسرطان (Makary & Daniel, 2016, BMJ).

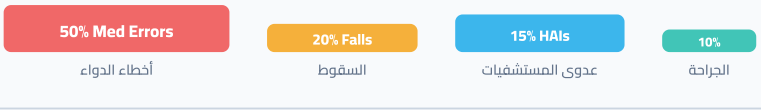
🔵 **WHO Report (2021):** Unsafe medication practices and errors cost $42 billion annually worldwide. 5% of all hospital admissions result in an adverse event.

🔵 **تقرير WHO (2021):** الممارسات الدوائية غير الآمنة والأخطاء تكلف 42 مليار دولار سنوياً عالمياً. 5% من دخول المستشفى ينتج عنه حدث ضار.

⚠ **Medication Errors:** Account for **50% of all preventable harm** in hospitals. The 5 Rights can prevent most of them!

⚠ **أخطاء الدواء:** تمثل **50% من كل الأضرار القابلة للمنع** بالمستشفيات. الحقوق الخمسة تمنع معظمها!

Top Causes of Patient Harm / أهم أسباب أذى المريض



🟢 **Good News:** With proper training, teamwork, and evidence-based protocols, **80% of patient harm is PREVENTABLE**!

🟢 **خبر سار:** مع التدريب الصحيح والعمل الجماعي والبروتوكولات المبنية على الأدلة، **80% من أذى المريض يمكن منعه**!

Sources: WHO (2021) Global Patient Safety Report • Makary & Daniel (2016) BMJ • AHRQ PSNet (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Latest Scientific Research / أحدث الأبحاث العلمية

Study 1: "To Err is Human" — Landmark

Findings: Up to 98,000 Americans die each year from preventable medical errors — more than car accidents, breast cancer, or AIDS.

النتائج: حتى 98,000 أمريكي يموتون سنوياً من أخطاء طبية يمكن منعها — أكثر من حوادث السيارات أو سرطان الثدي أو الإيدز.

Source: IOM / Kohn et al. (1999). To Err is Human. National Academies Press.

Study 2: Medical Errors = 3rd Cause of Death — Level II

Findings: Medical errors cause 251,454 deaths/year in the USA, making them the 3rd leading cause of death after heart disease and cancer.

النتائج: الأخطاء الطبية تسبب 251,454 وفاة/سنوياً في أمريكا، مما يجعلها ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان.

Source: Makary & Daniel (2016). Medical error — the third leading cause of death. BMJ, 353, i2139.

Study 3: SBAR Reduces Communication Errors — Level I

Findings: Implementation of SBAR communication reduced critical event reports by 30% and unexpected death rates by 17% in hospitals.

النتائج: تطبيق تواصل SBAR قلل تقارير الأحداث الحرجة بنسبة 30% ومعدلات الوفاة غير المتوقعة بنسبة 17% في المستشفيات.

Source: Randmaa et al. (2014). Am J Med Quality, 29(5), 409-418.

Study 4: Surgical Safety Checklist Saves Lives — Level I

Findings: WHO Surgical Safety Checklist reduced surgical mortality by 47% and complications by 36% in 8 countries worldwide.

النتائج: قائمة التحقق الجراحية لـ WHO قللت الوفيات الجراحية بنسبة 47% والمضاعفات بنسبة 36% في 8 دول حول العالم.

Source: Haynes et al. (2009). A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality. NEJM, 360(5), 491-499.

Study 5: Fall Prevention Programs Work — Level II

Findings: Multi-component fall prevention programs reduced inpatient falls by 25-30% and fall-related injuries by 28%.

النتائج: برامج الوقاية من السقوط المتعددة المكونات قللت سقوط المرضى الداخليين بنسبة 25-30% وإصابات السقوط بنسبة 28%.

Source: Morris & O'Riordan (2017). J Safety Research, 60, 97-103.

✓ **Clinical Implication:** Evidence strongly supports systematic safety interventions. SBAR, checklists, and fall programs SAVE LIVES!

✓ **التطبيق السريري:** الأدلة تدعم بقوة التدخلات المنهجية للسلامة. SBAR والقوائم وبرامج السقوط تنقذ الأرواح!

All studies peer-reviewed • Evidence Levels: I = Meta-Analysis, II = RCT, Landmark = Foundational.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

What is Patient Safety? / ما هي سلامة المريض؟

WHO Definition: Patient Safety is the **prevention of errors and adverse effects** associated with healthcare. It is a framework of organized activities that creates cultures, processes, procedures, behaviors, technologies, and environments that consistently and sustainably lower risks, reduce harm, and make errors less likely.

تعريف WHO: سلامة المريض هي **منع الأخطاء والآثار الضارة** المرتبطة بالرعاية الصحية. إطار من الأنشطة المنظمة التي تخلق ثقافات وعمليات وإجراءات وسلوكيات وتقنيات وبيئات تقلل المخاطر باستمرار، وتقلل الأضرار، وتجعل الأخطاء أقل احتمالاً.

Core Principle: Patient Safety is NOT about blame — it's about creating **SYSTEMS** that prevent errors and catch them before they reach the patient.

المبدأ الأساسي: سلامة المريض **مش** عن إلقاء اللوم — هي عن إنشاء **أنظمة** تمنع الأخطاء وتكتشفها قبل ما توصل للمريض.

The 4 Pillars of Patient Safety / الركائز الأربع لسلامة المريض



1. Safety Culture: Non-punitive environment where staff report errors freely.	**1. ثقافة السلامة:** بيئة غير عقابية حيث الطاقم يبلغ عن الأخطاء بحرية.
2. Safety Systems: Protocols, checklists, barriers that prevent errors.	**2. أنظمة السلامة:** بروتوكولات، قوائم تحقق، حواجز تمنع الأخطاء.
3. Teamwork: SBAR communication, handoffs, interprofessional collaboration.	**3. العمل الجماعي:** تواصل SBAR، تسليم النوبات، تعاون بين التخصصات.
4. Continuous Learning: RCA, incident analysis, quality improvement.	**4. التعلم المستمر:** تحليل السبب الجذري، تحليل الحوادث، تحسين الجودة.

⚠ Key Insight: Most errors are NOT caused by bad people — they're caused by bad SYSTEMS. Fix the system, not the person!

⚠ فكرة أساسية: معظم الأخطاء **مش** بسبب ناس سيئة — هي بسبب أنظمة سيئة. أصلح النظام، مش الشخص!

Nursing Role: Nurses spend the MOST time with patients — they are the LAST line of defense against medical errors!

دور التمريض: الممرضين يقضون أكثر وقت مع المرضى — هم **آخر خط دفاع** ضد الأخطاء الطبية!

Source: WHO (2021) Global Patient Safety Action Plan ▪ IHI (2023) Safety Framework ▪ Reason (2000) Human Error.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

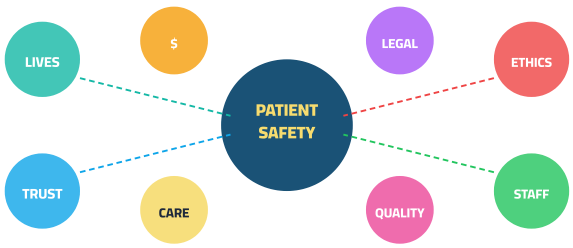
🎯 Why Patient Safety Matters / لماذا سلامة المريض مهمة؟

Core Concept: Patient safety is the **foundation of quality healthcare**. It saves lives, reduces suffering, saves money, and builds trust between patients and healthcare systems. No safety = no quality!

الفكرة الأساسية: سلامة المريض هي **أساس الرعاية الصحية الجيدة**. تنقذ الأرواح، تقلل المعاناة، توفر المال، وتبني الثقة بين المرضى والأنظمة الصحية. لا سلامة = لا جودة!

✅ 7 Key Reasons / 7 أسباب رئيسية

1	**Saves Lives:** Prevents 80% of medical errors that could kill patients.	**ينقذ الأرواح:** يمنع 80% من الأخطاء الطبية التي قد تقتل المرضى.
2	**Reduces Suffering:** Fewer complications = better quality of life.	**يقلل المعاناة:** مضاعفات أقل = جودة حياة أفضل.
3	**Saves Money:** $42 billion saved yearly by preventing adverse events.	**يوفر المال:** 42 مليار دولار يتم توفيرها سنوياً بمنع الأحداث الضارة.
4	**Builds Trust:** Patients trust safe hospitals and return for care.	**يبني الثقة:** المرضى يثقون في المستشفيات الآمنة ويعودون للرعاية.
5	**Legal Protection:** Reduces lawsuits and malpractice claims.	**حماية قانونية:** يقلل الدعاوى القضائية ومطالبات سوء الممارسة.
6	**Staff Wellbeing:** Safer environments reduce burnout and second-victim syndrome.	**رفاهية الطاقم:** بيئات أكثر أماناً تقلل الإرهاق ومتلازمة الضحية الثانية.
7	**Ethical Duty:** "First, do no harm" — the Hippocratic principle.	**واجب أخلاقي:** "أولاً، لا تسبب أذى" — المبدأ الأبقراطي.



⚠ **Reality Check:** Every 26 seconds, a patient dies globally due to unsafe healthcare. That's YOUR patient tomorrow if we don't act TODAY!

⚠ **تنبيه واقعي:** كل 26 ثانية، يموت مريض عالمياً بسبب رعاية غير آمنة. ده ممكن يكون مريضك بكرة لو ما اتحركناش النهاردة!

Source: WHO (2021) ▪ Slawomirski et al. (2017) OECD Report on Patient Safety.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🛡️ Foundation of Patient Safety / أساس سلامة المريض

Definition: Safety Culture is **"the way we do things around here"** when it comes to safety. It's the shared values, beliefs, and behaviors that prioritize patient safety in an organization.

التعريف: ثقافة السلامة هي **"الطريقة اللي بنعمل بها الأمور هنا"** فيما يخص السلامة. هي القيم والمعتقدات والسلوكيات المشتركة التي تضع سلامة المريض في المقدمة.

🔺 3 Types of Safety Culture / 3 أنواع لثقافة السلامة

✖ PUNITIVE	⚠ BLAME-FREE	✔ JUST CULTURE
ثقافة عقابية	**ثقافة بلا لوم**	**ثقافة عادلة**
▪ Blame individuals ▪ Fear of reporting ▪ Hide mistakes ▪ Repeat errors	▪ Report freely ▪ No accountability ▪ Miss patterns ▪ Weak system	▪ Balance accountability + learning ▪ Fair reporting ▪ Fix systems ▪ Prevent errors
⚠ WORST!	⚠ INCOMPLETE	✔ BEST!

⚖️ Just Culture Principles / مبادئ الثقافة العادلة

1	**Human Error:**	Console the person, fix the system.	**خطأ بشري:** واسي الشخص، أصلح النظام.
2	**At-Risk Behavior:**	Coach the person, address why the shortcut happened.	**سلوك خطر:** درّب الشخص، عالج سبب الاختصار.
3	**Reckless Behavior:**	Disciplinary action — person KNEW the risk.	**سلوك متهور:** إجراء تأديبي — الشخص **كان يعرف** الخطر.

🔑 Key Elements of Safety Culture / عناصر ثقافة السلامة

1. Leadership Commitment: Managers prioritize safety over profit.	**1. التزام القيادة:** المديرون يعطون الأولوية للسلامة على الربح.
2. Open Communication: Staff speak up without fear.	**2. تواصل مفتوح:** الطاقم يتحدث بحرية بدون خوف.
3. Continuous Learning: Errors are learning opportunities.	**3. التعلم المستمر:** الأخطاء فرص للتعلم.
4. Teamwork: Interprofessional collaboration.	**4. العمل الجماعي:** تعاون بين التخصصات.

💡 **Golden Rule:** "In a Just Culture, we don't ask WHO made the error, we ask WHY the error happened!"	💡 **القاعدة الذهبية:** "في الثقافة العادلة، ما نسألش **مين** عمل الخطأ، نسأل **ليه** الخطأ حصل!"

Source: Marx (2001) Just Culture Model ▪ AHRQ (2023) Safety Culture Assessment ▪ IHI Framework.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

16 Essential Patient Safety Terms / 16 مصطلح أساسي لسلامة المريض

English Term	المصطلح العربي	Definition / التعريف
Patient Safety	سلامة المريض	منع الأخطاء والآثار الضارة في الرعاية الصحية
Adverse Event	حدث ضار	إصابة سببها الرعاية الطبية، ليس المرض
Near Miss	حادث وشيك	خطأ تم اكتشافه قبل وصوله للمريض
Sentinel Event	حدث خطير	حدث غير متوقع يسبب موت أو أذى شديد
Medical Error	خطأ طبي	فشل في إكمال إجراء مخطط أو استخدام خطة خاطئة
Root Cause Analysis (RCA)	تحليل السبب الجذري	عملية منهجية لتحديد أسباب الأخطاء
Swiss Cheese Model	نموذج الجبنة السويسرية	نظرية تُظهر كيف تتراكم الأخطاء عبر الحواجز
IPSG	أهداف السلامة الدولية	6 أهداف من JCI لسلامة المريض
SBAR	تواصل SBAR	Situation-Background-Assessment-Recommendation
Handoff / Handover	تسليم النوبات	نقل مسؤولية رعاية المريض بين الطاقم
Time-Out	وقفة قبل الجراحة	توقف قبل الجراحة للتأكد من المريض/الإجراء
High-Alert Medications	أدوية عالية الخطورة	أدوية بأعلى مخاطر لأذى شديد إذا استخدمت خطأ
Never Event	حدث لا يجب حدوثه	حدث خطير يمكن منعه تماماً (جراحة الجانب الخطأ)
Fall Risk	خطر السقوط	احتمالية سقوط المريض أثناء الاستشفاء
Incident Report	تقرير الحادث	توثيق رسمي للأحداث والأخطاء
Just Culture	ثقافة عادلة	توازن بين المحاسبة والتعلم من الأخطاء

Study Tip: These 16 terms are the LANGUAGE of patient safety. Master them for JCI, NCLEX, and Prometric exams!

نصيحة للدراسة: الـ 16 مصطلح دول هم **لغة** سلامة المريض. اتقنهم لامتحانات JCI وNCLEX وPrometric!

Source: JCI Glossary (2023) ▪ AHRQ PSNet Terminology ▪ WHO Patient Safety Curriculum.

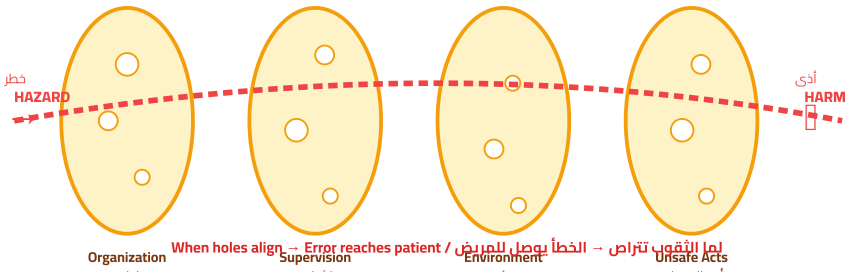
RN, Ali Ashour, BSN © 2025

James Reason's Theory of Accident Causation / نظرية جيمس ريزون لأسباب الحوادث

The Model: Developed by Prof. James Reason (2000), this model shows that in complex systems, multiple defenses (like slices of Swiss cheese) protect against errors. When holes ALIGN across all layers, an error reaches the patient.

النموذج: طوره بروفيسور جيمس ريزون (2000)، يُظهر هذا النموذج أنه في الأنظمة المعقدة، حواجز متعددة (مثل شرائح الجبنة السويسرية) تحمي من الأخطاء. عندما **تتراص الثقوب** عبر كل الطبقات، يصل الخطأ للمريض.

Swiss Cheese Model / نموذج الجبنة السويسرية



The 4 Defense Layers / طبقات الدفاع الأربع

1	**Organizational Influences:**	Policies, resources, staffing decisions.	**التأثيرات التنظيمية:** السياسات، الموارد، قرارات التوظيف.
2	**Unsafe Supervision:**	Inadequate training, poor teamwork, weak leadership.	**إشراف غير آمن:** تدريب غير كافٍ، عمل جماعي ضعيف، قيادة ضعيفة.
3	**Preconditions:**	Fatigue, stress, distractions, communication failures.	**الظروف المسبقة:** الإرهاق، التوتر، الانحرافات، فشل التواصل.
4	**Unsafe Acts:**	Actual errors and violations by frontline staff.	**الأفعال غير الآمنة:** الأخطاء الفعلية والانتهاكات من طاقم العمل.

Key Insight: Errors are usually caused by SYSTEM failures, not individual mistakes. Fix the holes in your system!

فكرة أساسية: الأخطاء عادةً بسبب **فشل النظام**، مش أخطاء فردية. أصلح الثقوب في نظامك!

Application: The more defenses you build, the harder it is for errors to reach the patient. Layer safety measures!

التطبيق: كلما بنيت دفاعات أكثر، صعب الخطأ يوصل للمريض. اعمل طبقات من إجراءات السلامة!

Source: Reason, J. (2000). Human error: models and management. BMJ, 320(7237), 768-770.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

International Patient Safety Goals (JCI) / أهداف السلامة الدولية للمرضى

Overview: The **6 International Patient Safety Goals (IPSG)** are the foundation of JCI accreditation. They address the most critical safety issues in healthcare and are MANDATORY for all accredited hospitals worldwide.

نظرة عامة: أهداف السلامة الدولية الست (IPSG) هي أساس اعتماد JCI. تعالج أهم مشاكل السلامة في الرعاية الصحية وهي **إلزامية** لكل المستشفيات المعتمدة عالمياً.

ID

1

Identify Patients Correctly
تعريف المريض الصحيح

→ Page 12

2

Effective Communication
التواصل الفعال

→ Page 13

3

High-Alert Medications
الأدوية عالية الخطورة

→ Page 14

4

Correct-Site Surgery
جراحة الموضع الصحيح

→ Page 15

5

Reduce Infection Risk
تقليل خطر العدوى

→ Page 16

6

Reduce Fall Risk
تقليل خطر السقوط

→ Page 17

What Each Goal Addresses / ما يعالجه كل هدف

1	**IPSG 1:** Prevent wrong-patient errors using 2 identifiers.	**IPSG 1:** منع أخطاء المريض الخطأ باستخدام مُعرّفين.
2	**IPSG 2:** Improve verbal & telephone orders (Read-back).	**IPSG 2:** تحسين الأوامر الشفهية والهاتفية (إعادة القراءة).
3	**IPSG 3:** Prevent medication errors with high-risk drugs.	**IPSG 3:** منع أخطاء الدواء مع الأدوية عالية الخطورة.
4	**IPSG 4:** Ensure right patient, right site, right procedure (Time-Out).	**IPSG 4:** ضمان المريض/الموضع/الإجراء الصحيح (Time-Out).
5	**IPSG 5:** Reduce healthcare-associated infections (HAIs).	**IPSG 5:** تقليل عدوى المستشفيات (HAIs).
6	**IPSG 6:** Reduce patient falls using risk assessment tools.	**IPSG 6:** تقليل سقوط المرضى باستخدام أدوات تقييم المخاطر.

Memory Trick "ICEMIF": **I**dentify + **C**ommunicate + **E**xtra-safe meds + **M**ark surgery + **I**nfection prevention + **F**all reduction

حيلة الحفظ "ICEMIF": تعريف + تواصل + أدوية آمنة + تعليم جراحي + منع عدوى + تقليل السقوط

Source: JCI (2023) 7th Edition Accreditation Standards ▪ NPSG.org ▪ Egyptian JCI Guidelines.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

ID

IPSG #1 OF 6

IDENTIFY PATIENTS CORRECTLY

تعريف المريض الصحيح

Goal: To reliably identify the individual as the correct patient before providing care, treatment, or services. Wrong-patient errors can be FATAL!

الهدف: التعرف بشكل موثوق على المريض قبل تقديم أي رعاية أو علاج أو خدمة. أخطاء تحديد المريض الخطأ ممكن تكون **قاتلة**!

✓

2 Approved Identifiers

مُعرِّفان معتمدان

- Full Name
- Date of Birth
- Medical Record #
- (NEVER room #!)

- الاسم الكامل
- تاريخ الميلاد
- رقم الملف الطبي
- (ممنوع رقم الغرفة!)

When to Verify?

متى نتحقق؟

- Before medications
- Before blood transfusion
- Before procedures
- Before diagnostic tests
- Before meal delivery

- قبل الأدوية
- قبل نقل الدم
- قبل الإجراءات
- قبل الفحوصات
- قبل توصيل الطعام

Verification Methods / طرق التحقق

1	**Ask patient:**"Please state your name and date of birth."	**اسأل المريض:**"من فضلك قل اسمك وتاريخ ميلادك"
2	**Check wristband:**Match with medication/order.	**افحص السوار:**طابقه مع الدواء/الأمر.
3	**Use technology:**Barcode scanning when available.	**استخدم التقنية:**مسح الباركود عند التوفر.
4	**Unconscious patients:**Verify with wristband + records + family.	**مرضى فاقدي الوعي:**تحقق بالسوار + السجلات + الأهل.

NEVER: Use room number or bed number as identifiers! Patients can be moved without your knowledge.

ممنوع: استخدام رقم الغرفة أو السرير كمُعرِّف! المرضى ممكن ينقلوا بدون علمك.

⚠ **High-Risk Situations:** Newborns, unconscious patients, patients with similar names, transfers between units.

⚠ **مواقف عالية الخطورة:** حديثي الولادة، فاقدي الوعي، مرضى بأسماء متشابهة، النقل بين الأقسام.

Real Case: A wrong blood transfusion killed a patient because staff only checked room number. ALWAYS use 2 identifiers!

حالة حقيقية: نقل دم خطأ قتل مريض لأن الطاقم اعتمد على رقم الغرفة فقط. **دائماً** استخدم مُعرِّفين!

Source: JCI IPSG 1 (2023) ▪ TJC National Patient Safety Goals ▪ AHRQ Patient Identification.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

IPSG #2 OF 6

EFFECTIVE COMMUNICATION
التواصل الفعال

Goal: Improve the effectiveness of communication among caregivers. Poor communication causes **66% of sentinel events**! Standardized handoffs save lives.

الهدف: تحسين فعالية التواصل بين مقدمي الرعاية. سوء التواصل يسبب **66% من الأحداث الخطيرة**! التسليم القياسي ينقذ الأرواح.

Verbal/Telephone Orders (Read-Back) / الأوامر الشفهية والهاتفية

1	**Write it Down:** Nurse writes complete order.	**اكتبه:** الممرض يكتب الأمر كاملاً.
2	**Read it Back:** Nurse reads order back to physician.	**اقرأه مرة ثانية:** الممرض يقرأ الأمر للطبيب.
3	**Confirm:** Physician confirms accuracy ("Correct").	**تأكيد:** الطبيب يؤكد الدقة ("صحيح").
4	**Document:** Sign as VO (verbal order) with time.	**وثّق:** وقّع كـ VO (أمر شفهي) مع الوقت.

Critical Test Results / نتائج الفحوصات الحرجة

Timeframe: Critical results (e.g., critical potassium level, positive blood culture) MUST be reported to physician within **30-60 minutes**. Use SBAR format for reporting.

الإطار الزمني: النتائج الحرجة (مثل مستوى بوتاسيوم حرج، مزرعة دم إيجابية) **يجب** إبلاغ الطبيب خلال **30-60 دقيقة**. استخدم SBAR للتبليغ.

SBAR Communication Framework / إطار تواصل SBAR

S	B	A	R
Situation الموقف "What's happening now?"	**Background** الخلفية "What led to this?"	**Assessment** التقييم "What do I think?"	**Recommendation** التوصية "What should we do?"

Handoff Standards: Use standardized tools (SBAR, I-PASS) during shift change, patient transfer, and physician communication.

معايير التسليم: استخدم أدوات موحدة (SBAR، I-PASS) عند تغيير النوبة، نقل المريض، والتواصل مع الطبيب.

Never Use: Abbreviations from the "Do Not Use" list! (e.g., U for units → write "units")

ممنوع: استخدام اختصارات من قائمة "لا تستخدم"! (مثل U للوحدات ← اكتب "وحدات")

Study: Implementing SBAR reduced critical events by 30% (Randmaa et al., 2014). It WORKS!

دراسة: تطبيق SBAR قلل الأحداث الحرجة بنسبة 30% (Randmaa et al., 2014). **بيشتغل**!

Source: JCI IPSG 2 (2023) ▪ ISMP Do Not Use List ▪ Institute for Healthcare Improvement (IHI).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

IPSG #3 OF 6

HIGH-ALERT MEDICATIONS
الأدوية عالية الخطورة

Goal: Improve safety of high-alert medications. These drugs have the HIGHEST risk of causing significant harm when used in error, even if used as intended.

الهدف: تحسين سلامة الأدوية عالية الخطورة. هذه الأدوية لديها **أعلى خطر** لإحداث ضرر كبير عند استخدامها بشكل خطأ، حتى لو استخدمت كما هو مقصود.

⚠ Top High-Alert Medications (ISMP List) / أهم الأدوية عالية الخطورة

Insulin: Wrong dose → hypoglycemia coma/death	**الأنسولين:** جرعة خطأ ← غيبوبة/وفاة نقص السكر
Heparin: Wrong dose → severe bleeding	**الهيبارين:** جرعة خطأ ← نزيف شديد
Warfarin: INR imbalance → clot or bleeding	**الوارفارين:** عدم توازن INR ← جلطة أو نزيف
Potassium (KCl): Rapid IV push → cardiac arrest	**البوتاسيوم (KCl):** دفع سريع IV ← سكتة قلبية
Opioids (Morphine, Fentanyl): Overdose → respiratory arrest	**المسكنات الأفيونية:** جرعة زائدة ← فشل تنفسي
Chemotherapy: Extravasation → severe tissue damage	**العلاج الكيماوي:** تسرب ← تلف نسيجي شديد

Safety Measures / إجراءات السلامة

1	**Independent Double-Check:**	Two RNs verify dose before administration.	**فحص مزدوج مستقل:** ممرضان يتحققان من الجرعة قبل الإعطاء.
2	**Separate Storage:**	Store high-alert meds in dedicated locked areas.	**تخزين منفصل:** خزّن الأدوية عالية الخطورة في أماكن مقفلة مخصصة.
3	**Warning Labels:**	Bright colored labels (red/yellow) on all high-alert drugs.	**ملصقات تحذيرية:** ملصقات ملونة (أحمر/أصفر) على كل الأدوية عالية الخطورة.
4	**Standard Concentrations:**	Use pre-mixed IV bags to reduce errors.	**تركيزات موحدة:** استخدم أكياس IV جاهزة لتقليل الأخطاء.
5	**Smart Pumps:**	Use IV pumps with drug libraries and dose limits.	**مضخات ذكية:** استخدم مضخات IV مع مكتبة أدوية وحدود جرعات.
6	**Barcode Scanning:**	Scan patient wristband + medication before giving.	**مسح الباركود:** امسح سوار المريض + الدواء قبل الإعطاء.

CRITICAL: Concentrated KCl (potassium) is **NEVER** to be stored in patient care areas! Only in pharmacy!

حرج جداً: KCl المركز (البوتاسيوم) **ممنوع منعاً باتاً** تخزينه في أماكن رعاية المرضى! فقط في الصيدلية!

LASA: Watch for "Look-Alike, Sound-Alike" drugs (e.g., Hydralazine vs Hydroxyzine). Use TALL man letters!

LASA: انتبه للأدوية "المتشابهة في الشكل والاسم" (مثل: Hydralazine vs Hydroxyzine). استخدم الحروف الكبيرة!

Source: JCI IPSG 3 (2023) ▪ ISMP High-Alert Medications List ▪ Egyptian MOH Drug Safety.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

IPSG #4 OF 6

CORRECT-SITE SURGERY
جراحة الموضع الصحيح

Goal: Ensure the RIGHT patient, RIGHT surgery, and RIGHT site. Wrong-site surgery is a **"Never Event"** — it should NEVER happen but occurs 40+ times/week in the USA!

الهدف: ضمان **المريض الصحيح**، **الجراحة الصحيحة**، **الموضع الصحيح**. جراحة الجانب الخطأ هي **"حدث لا يجب حدوثه"** — يجب ألا يحدث أبداً لكن يحدث 40+ مرة/أسبوع في أمريكا!

The 3 Critical Steps (Universal Protocol) / الخطوات الثلاث الحرجة

Universal Protocol / البروتوكول العالمي

1 Pre-Op Verify	2 Site Marking	3 Time-Out
▪ Verify patient ID ▪ Confirm procedure ▪ Check consent form تحقق قبل العملية	▪ Mark with skin marker ▪ Sign initials on site ▪ Patient sees mark تعليم الموضع	▪ Whole team pauses ▪ Verify aloud together ▪ Document in chart وقفة نهائية

Time-Out Checklist / قائمة تحقق الـ Time-Out

1	**Correct Patient** identified (2 identifiers)	**المريض الصحيح** تم التعرف عليه (مُعرِّفان)
2	**Correct Procedure** confirmed with consent form	**الإجراء الصحيح** تم تأكيده بنموذج الموافقة
3	**Correct Site** marked and visible	**الموضع الصحيح** معلّم وواضح
4	**Correct Position** for procedure	**الوضعية الصحيحة** للإجراء
5	**All Equipment** and imaging available	**كل المعدات** والصور الشعاعية متوفرة
6	**Antibiotics** given if indicated	**المضادات الحيوية** أعطيت إن لزم

WHO Study: Surgical Safety Checklist reduced deaths by 47% and complications by 36% globally!

دراسة WHO: قائمة السلامة الجراحية قللت الوفيات بنسبة 47% والمضاعفات بنسبة 36% عالمياً!

STOP if in doubt: Any team member can STOP the surgery if something feels wrong. Speak up!

توقف عند الشك: أي عضو في الفريق يقدر يوقف الجراحة لو حسّ إن فيه حاجة غلط. **اتكلم**!

Source: JCI IPSG 4 (2023) ▪ WHO Surgical Safety Checklist ▪ Haynes et al. (2009) NEJM.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

IPSG #5 OF 6

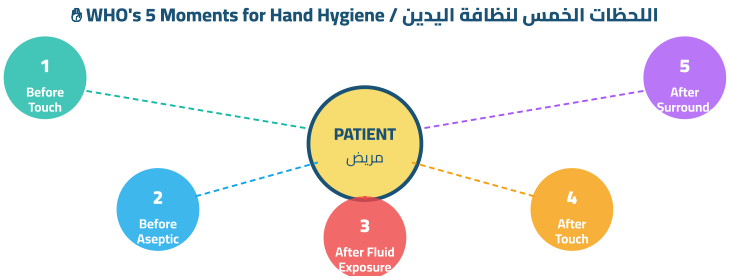
REDUCE INFECTION RISK

تقليل خطر العدوى

Goal: Reduce the risk of healthcare-associated infections (HAIs). Focus on **hand hygiene** as the #1 intervention — simple but life-saving!

الهدف: تقليل خطر عدوى المستشفيات (HAIs). التركيز على **نظافة اليدين** كأهم تدخل — بسيط لكنه ينقذ الأرواح!

WHO 5 Moments for Hand Hygiene / اللحظات الخمس لنظافة اليدين



Types of HAIs to Prevent / أنواع عدوى المستشفيات

1	**CLABSI:**Central Line-Associated Bloodstream Infection	**CLABSI:**عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة المركزية
2	**CAUTI:**Catheter-Associated Urinary Tract Infection	**CAUTI:**التهاب المسالك البولية المرتبط بالقسطرة
3	**VAP:**Ventilator-Associated Pneumonia	**VAP:**الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس
4	**SSI:**Surgical Site Infection	**SSI:**عدوى الموضع الجراحي

Alcohol Rub vs Soap: Alcohol rub (70%) preferred for routine care. Soap+water for visibly soiled hands, C.diff, or gross contamination.

الكحول vs الصابون: الكحول (70%) للرعاية الروتينية. الصابون والماء للأيدي الملوثة بصرياً، C.diff، أو التلوث الشديد.

Bundle Approach: Use "care bundles" (5-6 evidence-based interventions) to prevent HAIs. Bundles work!

نهج الحزمة: استخدم "حزم الرعاية" (5-6 تدخلات مبنية على الأدلة) لمنع HAIs. الحزم بتشتغل!

Source: JCI IPSG 5 (2023) ▪ WHO 5 Moments for Hand Hygiene ▪ CDC HAI Prevention.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

IPSG #6 OF 6

REDUCE PATIENT FALLS

تقليل سقوط المرضى

Goal: Assess and reduce fall risk. Patient falls are the #1 reported adverse event in hospitals — causing 250,000+ injuries and $34 billion/year in costs!

الهدف: تقييم وتقليل خطر السقوط. سقوط المرضى هو **الحدث الضار الأكثر إبلاغاً** في المستشفيات — يسبب أكثر من 250,000 إصابة و34 مليار دولار سنوياً!

Morse Fall Scale (MFS) / مقياس مورس للسقوط

Score Interpretation: 0-24 = LOW risk ▪ 25-50 = MODERATE risk ▪ ≥51 = HIGH risk (needs immediate intervention!)

تفسير النتيجة: 0-24 = خطر **منخفض** ▪ 25-50 = خطر **متوسط** ▪ ≥51 = خطر **عالي** (يحتاج تدخل فوري!)

⚠ Fall Risk Factors / عوامل خطر السقوط

Age: >65 years (highest risk)	**العمر:** >65 سنة (أعلى خطر)
Medications: Sedatives, opioids, diuretics	**الأدوية:** المهدئات، المسكنات الأفيونية، مدرات البول
Cognitive: Confusion, dementia, delirium	**معرفي:** ارتباك، خرف، هذيان
Mobility: Weakness, unsteady gait, dizziness	**الحركة:** ضعف، مشية غير مستقرة، دوخة
History: Previous falls in last 3 months	**التاريخ:** سقوط سابق في آخر 3 شهور
Nocturia: Frequent night urination	**التبول الليلي:** تبول ليلي متكرر

Fall Prevention Interventions / تدخلات الوقاية من السقوط

1	**Yellow Wristband:** Identify high-risk patients visually.	**سوار أصفر:** تعريف المرضى عاليي الخطورة بصرياً.
2	**Bed Alarms:** Alert staff when patient tries to get up.	**أجهزة إنذار السرير:** تنبيه الطاقم عند محاولة النهوض.
3	**Non-Slip Socks:** Yellow socks for high-risk patients.	**جوارب مضادة للانزلاق:** جوارب صفراء لعاليي الخطورة.
4	**Bed Position:** Low position with brakes locked, side rails up.	**وضعية السرير:** منخفض مع فرامل مقفلة، حواجز جانبية مرفوعة.
5	**Call Bell:** Within patient's reach, teach patient to use it.	**جرس الاستدعاء:** في متناول المريض، علّمه كيف يستخدمه.
6	**Toileting Rounds:** Every 2 hours to prevent urgency.	**جولات الحمام:** كل ساعتين لمنع الحاجة العاجلة.
7	**Clear Environment:** No clutter, dry floors, good lighting.	**بيئة خالية من العوائق:** ممنوع الفوضى، أرضيات جافة، إضاءة جيدة.

Post-Fall Protocol: Assess vitals + Neuro check + Document + Report + Reassess risk. Never move a fallen patient without assessment!

بروتوكول بعد السقوط: تقييم العلامات + فحص عصبي + توثيق + بلاغ + إعادة تقييم. **ممنوع** تحريك المريض قبل التقييم!

Family Involvement: Educate family about fall risks. Ask them to call for help before assisting patient.

مشاركة الأسرة: علّم الأسرة عن مخاطر السقوط. اطلب منهم استدعاء المساعدة قبل مساعدة المريض.

Source: JCI IPSG 6 (2023) ▪ Morse Fall Scale ▪ AHRQ Fall Prevention Toolkit.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

18 — Types of Medical Errors أنواع الأخطاء الطبية

⚠ Classification of Errors / تصنيف الأخطاء

Concept: Understanding error types helps us prevent them. James Reason classifies errors into **3 main categories**: Slips, Mistakes, and Violations.

الفكرة: فهم أنواع الأخطاء يساعدنا على منعها. جيمس ريزون يصنف الأخطاء لـ **3 فئات رئيسية**: Slips، Mistakes، Violationsg.

1 SLIPS & LAPSES / زلات وسهو — Skill-Based Error

What: Unintended action when doing something automatic (e.g., typing wrong dose while thinking about something else).

Cause: Distraction, fatigue, interruption

Example: Nurse gives Insulin instead of Heparin (mixed up vials)

Solution: Reduce distractions, use double-checks, standardize processes

2 MISTAKES / أخطاء الحكم — Knowledge-Based Error

What: Wrong plan due to incorrect knowledge or misdiagnosis.

Cause: Insufficient training, wrong information, faulty reasoning

Example: Giving beta-blocker to asthmatic patient (contraindicated)

Solution: Continuous education, clinical decision support, protocols

3 VIOLATIONS / انتهاكات — Intentional Deviation

What: Deliberate deviation from safety procedures.

Cause: Time pressure, understaffing, "shortcut" mentality

Example: Not doing hand hygiene between patients (routine violation)

Solution: Just Culture, address root causes, disciplinary action if reckless

Error Severity Classification / تصنيف شدة الأخطاء

A	**Near Miss:** Error caught BEFORE reaching patient (no harm)	**حادث وشيك:** خطأ تم اكتشافه **قبل** وصوله للمريض (بلا ضرر)
B	**No Harm Event:** Error reached patient but no harm occurred	**حدث بلا ضرر:** الخطأ وصل للمريض لكن بلا ضرر
C	**Adverse Event:** Error caused temporary harm requiring intervention	**حدث ضار:** الخطأ سبب ضرر مؤقت يحتاج تدخل
D	**Sentinel Event:** Serious harm, permanent injury, or death	**حدث خطير:** ضرر جسيم، إصابة دائمة، أو وفاة

Never Events: Errors that should NEVER happen — wrong-site surgery, wrong-patient blood transfusion, retained foreign objects.

أحداث لا يجب حدوثها: أخطاء يجب أن **لا تحدث أبداً** — جراحة الجانب الخطأ، نقل دم لمريض خطأ، أدوات متروكة بالجسم.

Learning Point: Report ALL errors, even near misses! They reveal system weaknesses before harm occurs.

نقطة تعلم: بلّغ عن **كل** الأخطاء، حتى الحوادث الوشيكة! تكشف نقاط ضعف النظام قبل حدوث الضرر.

Source: Reason (2000) BMJ ▪ NCC MERP Index ▪ AHRQ Common Formats.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

19 — The 5 Rights of Medication ⭐ | الحقوق الخمسة لإعطاء الأدوية

💊 The Foundation of Medication Safety / أساس سلامة الدواء

Concept: The "5 Rights" are the GOLD STANDARD for safe medication administration. Following them prevents up to 80% of medication errors!

الفكرة: "الحقوق الخمسة" هي **المعيار الذهبي** لإعطاء الأدوية بأمان. اتباعها يمنع حتى 80% من أخطاء الدواء!

1	**RIGHT PATIENT** Use 2 identifiers (name + DOB). Check wristband. Ask patient to state name.	**المريض الصحيح** استخدم مُعرِّفين (اسم + تاريخ ميلاد). افحص السوار. اطلب من المريض قول اسمه.
2	**RIGHT MEDICATION** Check label 3 times: when taking, preparing, and giving. Verify against order.	**الدواء الصحيح** افحص الملصق 3 مرات: عند الأخذ، التحضير، والإعطاء. طابق مع الأمر.
3	**RIGHT DOSE** Verify dose with calculator if needed. Double-check high-alert medications.	**الجرعة الصحيحة** تحقق من الجرعة بالحاسبة إن لزم. افحص مرتين للأدوية عالية الخطورة.
4	**RIGHT ROUTE** Check order for route (PO, IV, IM, SC). Never assume — different routes = different doses!	**الطريق الصحيح** افحص الأمر للطريق (فم، وريد، عضل). ممنوع الافتراض — طرق مختلفة = جرعات مختلفة!
5	**RIGHT TIME** Give within 30 min of scheduled time. Check last dose. Consider peak/trough for certain drugs.	**الوقت الصحيح** أعط خلال 30 دقيقة من الوقت المحدد. افحص آخر جرعة. اعتبر Peak/Trough لبعض الأدوية.

➕ Extended Rights (Modern Practice) / الحقوق الإضافية

6. Right Documentation: Record immediately after giving	**6. التوثيق الصحيح:** سجّل فوراً بعد الإعطاء
7. Right Reason: Understand WHY the drug is prescribed	**7. السبب الصحيح:** افهم **لماذا** الدواء موصوف
8. Right Response: Monitor patient's response	**8. الاستجابة الصحيحة:** راقب استجابة المريض
9. Right Education: Teach patient about the medication	**9. التعليم الصحيح:** علّم المريض عن الدواء
10. Right to Refuse: Patient can refuse (document it!)	**10. الحق في الرفض:** المريض له الحق يرفض (وثّق ده!)

🔢 **The 3 Checks:** Check medication (1) when removing from stock, (2) before preparing, (3) before giving to patient.

🔢 **الفحوصات الثلاثة:** افحص الدواء (1) عند الأخذ من المخزن، (2) قبل التحضير، (3) قبل الإعطاء للمريض.

🚨 **Golden Rule:** "If in doubt, DON'T give it!" Always verify with pharmacist or physician when unsure.

🚨 **القاعدة الذهبية:** "لو في شك، **ما تعطيهوش**!" دايماً تحقق مع الصيدلي أو الطبيب لما تكون مش متأكد.

Source: ISMP (2023) • ANA Medication Safety Standards • JCI Pharmaceutical Care.

📋 System for Reporting Errors / نظام الإبلاغ عن الأخطاء

Purpose: Incident reporting is **NOT about blame**. It's about identifying system weaknesses to prevent future errors. Reports should be timely, accurate, and blame-free.

الغرض: الإبلاغ عن الحوادث **ليس عن اللوم**. هو عن تحديد نقاط ضعف النظام لمنع الأخطاء المستقبلية. يجب أن تكون التقارير في الوقت المناسب، دقيقة، وخالية من اللوم.

⚠ What to Report / ماذا نبلّغ عنه

1	**Medication Errors:** Wrong drug/dose/route/time/patient	**أخطاء الدواء:** دواء/جرعة/طريق/وقت/مريض خطأ
2	**Patient Falls:** Any fall with or without injury	**سقوط المرضى:** أي سقوط بإصابة أو بدون
3	**Wrong Procedures:** Wrong-site, wrong-patient, wrong-procedure	**إجراءات خطأ:** موضع خطأ، مريض خطأ، إجراء خطأ
4	**Equipment Failure:** Broken pumps, monitors, ventilators	**فشل المعدات:** مضخات، أجهزة مراقبة، أجهزة تنفس معطلة
5	**Near Misses:** Caught errors before reaching patient	**حوادث وشيكة:** أخطاء اكتشفت قبل وصولها للمريض
6	**Needlestick Injuries:** Any sharps injury to staff	**وخز الإبر:** أي إصابة بأدوات حادة للطاقم
7	**Patient Complaints:** About safety, care, or communication	**شكاوى المرضى:** عن السلامة، الرعاية، أو التواصل

📝 Report Content (SBAR-Style) / محتوى التقرير

📋 **Patient Info:** Name, MRN, age, diagnosis (anonymized if needed)	📋 **بيانات المريض:** اسم، رقم ملف، عمر، تشخيص (مجهول إن لزم)
📅 **Date/Time:** Exact date and time of incident	📅 **التاريخ/الوقت:** تاريخ ووقت الحادث بدقة
📍 **Location:** Unit, room number, area	📍 **المكان:** القسم، رقم الغرفة، المنطقة
📝 **Description:** What happened (facts, not opinions)	📝 **الوصف:** ماذا حدث (حقائق، لا آراء)
👥 **Persons Involved:** Staff (not to blame, for follow-up)	👥 **الأشخاص المشاركون:** الطاقم (ليس للوم، للمتابعة)
🔍 **Outcome:** Was patient harmed? Actions taken?	🔍 **النتيجة:** هل تضرر المريض؟ الإجراءات المتخذة؟

⚠ **Do NOT:** Place incident report in patient's chart! Keep it in quality department. Chart only clinical facts.

⚠ **ممنوع:** وضع تقرير الحادث في ملف المريض! خزّنه في قسم الجودة. سجّل فقط الحقائق السريرية.

ℹ **Anonymous Reporting:** Most hospitals allow anonymous reports to encourage transparency and reduce fear.

ℹ **الإبلاغ المجهول:** معظم المستشفيات تسمح بالتقارير المجهولة لتشجيع الشفافية وتقليل الخوف.

⏱ **Timeframe:** Report within **24 hours** for regular events, **immediately** for sentinel events.

⏱ **الإطار الزمني:** بلّغ خلال **24 ساعة** للأحداث العادية، **فوراً** للأحداث الخطيرة.

Source: JCI Sentinel Events Policy • AHRQ Common Formats • ANA Reporting Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

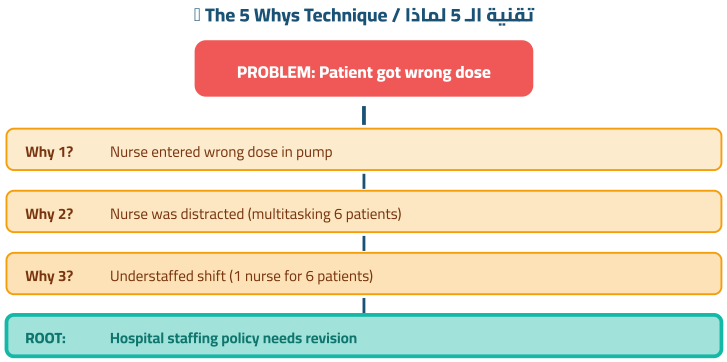
21 — Root Cause Analysis (RCA) تحليل السبب الجذري

🔍 Digging Deep to Find WHY / "التعمق لإيجاد "لماذا

Definition: RCA is a **systematic process** for identifying the underlying causes of an error. It answers: What happened? Why did it happen? What can we do to prevent it?

التعريف: RCA هو **عملية منهجية** لتحديد الأسباب الكامنة للخطأ. يجيب على: ماذا حدث؟ لماذا حدث؟ ماذا نفعل لمنعه؟

🔗 The 5 Whys Technique / تقنية الـ 5 لماذا



📋 RCA Process Steps / خطوات عملية RCA

1 — Assemble RCA Team

EN: Include frontline staff, managers, and experts. Aim for diverse perspectives.
AR: شكّل فريق يضم طاقم الخط الأمامي، المديرين، والخبراء. اهدف لتنوع الآراء.

2 — Gather Data

EN: Review records, interview staff, examine equipment, timeline of events.
AR: راجع السجلات، قابل الطاقم، افحص المعدات، جدول زمني للأحداث.

3 — Identify Contributing Factors

EN: Use "5 Whys" or Fishbone Diagram to explore root causes.
AR: استخدم "5 لماذا" أو مخطط عظمة السمكة لاستكشاف الأسباب الجذرية.

4 — Develop Action Plan

EN: Create SMART goals to address root causes (not just symptoms).
AR: ضع أهداف SMART (ليس فقط الأعراض) لمعالجة الأسباب الجذرية.

5 — Implement & Monitor

EN: Roll out changes, monitor outcomes, adjust as needed. Follow up in 30/60/90 days.
AR: نفّذ التغييرات، راقب النتائج، اضبط حسب الحاجة. تابع بعد 30/60/90 يوم.

⚠ **Common Pitfall:** Stopping at "human error" — that's a symptom, not a root cause! Ask WHY the person made the error.

⚠ **خطأ شائع:** التوقف عند "خطأ بشري" — ده عرض، مش سبب جذري! اسأل **لماذا** الشخص عمل الخطأ.

✅ **Golden Rule:** Fix the SYSTEM, not the PERSON. Address processes, resources, and environment.

✅ **القاعدة الذهبية:** أصلح **النظام**، مش **الشخص**. عالج العمليات، الموارد، والبيئة.

Source: JCI RCA Framework ▪ IHI Root Cause Analysis Toolkit ▪ VHA RCA Guide.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🏆 The Gold Standard for Handoff / المعيار الذهبي للتسليم

Definition: SBAR is a **structured communication tool** developed by the US Navy and adapted for healthcare. It provides a clear framework for delivering critical information in a concise, organized manner.

التعريف: SBAR هي **أداة تواصل منظمة** طورتها البحرية الأمريكية وتم تكييفها للرعاية الصحية. توفر إطار واضح لتقديم المعلومات الحرجة بشكل موجز ومنظم.

📋 SBAR Detailed Breakdown / تفصيل SBAR

S	**SITUATION (10 sec)** Your name + unit + patient name + reason for call. "This is Ali, ICU. Calling about Mr. Ahmed in bed 3 — his BP is 70/40."	**الموقف (10 ثواني)** اسمك + قسمك + اسم المريض + سبب الاتصال. "أنا علي من ICU، بتصل بخصوص السيد أحمد، سرير 3 — ضغطه 70/40."
B	**BACKGROUND (30 sec)** Diagnosis + relevant history + current treatment. "65 y/o, admitted 3 days ago with pneumonia, on Vancomycin, has DM & HTN."	**الخلفية (30 ثانية)** التشخيص + التاريخ الطبي + العلاج الحالي. "65 سنة، دخل من 3 أيام بالتهاب رئوي، على فانكوميسين، عنده سكر وضغط"
A	**ASSESSMENT (30 sec)** Your professional opinion. "I think he's septic — BP dropping, temp 39, HR 130, lactate elevated."	**التقييم (30 ثانية)** رأيك المهني. "أعتقد أنه في حالة إنتان — الضغط ينخفض، الحرارة 39، النبض 130، اللاكتات مرتفع"
R	**RECOMMENDATION (10 sec)** What do you need? "Can you come assess him? Should I start fluid bolus and increase norepinephrine?"	**التوصية (10 ثواني)** ماذا تحتاج؟ "ممكن تيجي تفحصه؟ هل أبدأ Fluid Bolus وأزود Norepinephrine؟"

🎯 When to Use SBAR / متى نستخدم SBAR

1	**Calling physician**about patient change/deterioration	**الاتصال بالطبيب**عن تغير/تدهور المريض
2	**Shift change handoff**(nurse-to-nurse)	**تسليم النوبة**(ممرض لممرض)
3	**Patient transfer**to another unit	**نقل المريض**لقسم آخر
4	**Critical lab results**reporting	**الإبلاغ عن نتائج معملية حرجة**
5	**Emergency situations**(rapid response, code blue)	**حالات الطوارئ**(استجابة سريعة، Code Blue)

ℹ **Evidence:** SBAR reduced critical events by 30% and unexpected deaths by 17% (Randmaa et al., 2014).

ℹ **الأدلة:** SBAR قللت الأحداث الحرجة بنسبة 30% والوفيات غير المتوقعة بنسبة 17% (Randmaa et al., 2014).

💡 **Practice Tip:** Write your SBAR BEFORE calling. Keep it under 90 seconds total. Be concise!

💡 **نصيحة عملية:** اكتب SBAR بتاعك **قبل** الاتصال. خليه أقل من 90 ثانية. كن موجزاً!

Source: IHI SBAR Toolkit • JCI Communication Standards • Kaiser Permanente SBAR Origins.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Transfer of Patient Care Responsibility / نقل مسؤولية الرعاية

Definition: Handoff is the **transfer of patient care responsibility** from one caregiver to another. Poor handoffs cause 80% of serious medical errors — making them a CRITICAL safety issue.

التعريف: التسليم هو **نقل مسؤولية رعاية المريض** من مقدم رعاية لآخر. سوء التسليم يسبب 80% من الأخطاء الطبية الخطيرة — مما يجعله **قضية سلامة حرجة**.

I-PASS Handoff Format / تنسيق I-PASS للتسليم

I	**ILLNESS SEVERITY** Stable, watcher, or unstable? Priority level.	**شدة المرض** مستقر، تحت المراقبة، أو غير مستقر؟ مستوى الأولوية.
P	**PATIENT SUMMARY** Brief description: name, age, dx, current status.	**ملخص المريض** وصف موجز: اسم، عمر، تشخيص، الحالة الحالية.
A	**ACTION LIST** What needs to be done? Include timeline and responsibility.	**قائمة المهام** ما يجب عمله؟ اشمل الجدول الزمني والمسؤولية.
S	**SITUATION AWARENESS** What might happen? Contingency plans (if X, then Y).	**الوعي بالموقف** ماذا قد يحدث؟ خطط الطوارئ (لو X، فـ Y).
S	**SYNTHESIS BY RECEIVER** Receiver summarizes back to confirm understanding.	**تلخيص المستلم** المستلم يلخص للتأكد من الفهم.

Handoff Best Practices / أفضل ممارسات التسليم

1	**Face-to-Face:**Whenever possible, do handoff bedside	**وجه لوجه:**كلما أمكن، اعمل التسليم عند سرير المريض
2	**Standardized:**Use I-PASS or SBAR format consistently	**موحد:**استخدم I-PASS أو SBAR بشكل منتظم
3	**Minimize Interruptions:**Quiet environment, no phone calls	**قلل المقاطعات:**بيئة هادئة، بدون مكالمات
4	**Active Involvement:**Include patient/family when possible	**مشاركة نشطة:**اشمل المريض/العائلة إن أمكن
5	**Verify Understanding:**Ask receiver to repeat critical info	**تأكد من الفهم:**اطلب من المستلم إعادة المعلومات الحرجة
6	**Document:**Both givers and receivers sign electronic handoff	**وثّق:**المسلّم والمستلم يوقعا على التسليم الإلكتروني

⚠ **High-Risk Times:** Shift changes, unit transfers, physician handoffs. Be extra vigilant!

⚠ **أوقات عالية الخطورة:** تغيير النوبات، النقل بين الأقسام، تسليم الأطباء. كن أكثر يقظة!

Study: I-PASS reduced medical errors by 23% and preventable adverse events by 30% (Starmer et al., 2014, NEJM).

دراسة: I-PASS قللت الأخطاء الطبية بنسبة 23% والأحداث الضارة القابلة للمنع بنسبة 30% (Starmer et al., 2014, NEJM).

Source: I-PASS Institute ▪ JCI Handoff Standards ▪ Starmer et al. (2014) NEJM.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

24 — Documentation Standards | معايير التوثيق

⚖️ Legal & Safety Documentation / التوثيق القانوني والسلامة

Principle: "If it wasn't documented, it wasn't done!" Documentation is the LEGAL record of patient care — it protects patients, staff, and institutions.

المبدأ: "لو ما اتوثقش، ما اتعملش!" التوثيق هو السجل **القانوني** لرعاية المريض — يحمي المرضى والطاقم والمؤسسات.

✓ Elements of Good Documentation / عناصر التوثيق الجيد

1	**Accurate:**Facts only, no assumptions or opinions	**دقيق:**حقائق فقط، لا افتراضات أو آراء
2	**Timely:**Chart AS SOON AS possible after event	**في الوقت المناسب:**وثّق في أسرع وقت بعد الحدث
3	**Complete:**Include all relevant details	**كامل:**اشمل كل التفاصيل ذات الصلة
4	**Legible:**Handwriting must be readable (or use EMR)	**واضح:**الخط يجب أن يكون مقروء (أو استخدم EMR)
5	**Signed:**Every entry with name, title, date, time	**موقّع:**كل إدخال باسم، لقب، تاريخ، وقت
6	**Objective:**Describe behavior, not judgments	**موضوعي:**صف السلوك، ليس الأحكام
7	**Chronological:**Events in order of occurrence	**زمني:**الأحداث بترتيب حدوثها

✗ What NOT to Document / ما يجب تجنبه

✗ **Personal opinions:** "Patient is difficult"	✗ **آراء شخصية:** "المريض صعب"
✗ **Blame:** "Dr. X was late"	✗ **اللوم:** "د. X تأخر"
✗ **Incident report reference:** Never mention in chart!	✗ **الإشارة لتقرير الحادث:** ممنوع ذكره بالملف!
✗ **Vague terms:** "Doing okay" — be specific!	✗ **مصطلحات غامضة:** "بخير" — كن محدداً!
✗ **Erasing/whiteout:** Cross out with single line + initial	✗ **المسح:** اشطب بخط واحد + وقّع بالأحرف الأولى
✗ **Late entries without noting:** Mark "Late Entry" clearly	✗ **إدخالات متأخرة بدون توضيح:** ضع "إدخال متأخر" بوضوح

⚖️ **Legal Warning:** In court, poor documentation = poor care. Complete charts protect you from lawsuits!

⚖️ **تحذير قانوني:** في المحكمة، توثيق سيء = رعاية سيئة. الملفات الكاملة تحميك من الدعاوى!

ℹ **EMR Tips:** Log off when leaving computer. Never share passwords. Use copy-paste carefully to avoid errors.

ℹ **نصائح EMR:** سجّل خروج عند ترك الكمبيوتر. لا تشارك كلمات السر. استخدم النسخ واللصق بحذر.

✓ **Golden Rule:** Chart as if a lawyer will read it in 5 years. Be accurate, objective, and complete!

✓ **القاعدة الذهبية:** وثّق كأن محامي سيقرأ الملف بعد 5 سنين. كن دقيقاً، موضوعياً، وشاملاً!

Source: ANA Nursing Documentation Standards • JCI Record Standards • HIPAA Compliance.

⚖ Universal Patient Rights (WHO/JCI) / حقوق المريض العالمية

Foundation: Every patient has inherent rights protected by law and international standards. Respecting these rights is a **legal AND ethical obligation** for every nurse.

الأساس: كل مريض له حقوق أصيلة محمية بالقانون والمعايير الدولية. احترام هذه الحقوق واجب **قانوني وأخلاقي** لكل ممرض.

1	**Right to Safe Care:** Free from harm, injury, or neglect	**الحق في رعاية آمنة:** بلا ضرر أو إصابة أو إهمال
2	**Right to Dignity:** Respectful treatment regardless of race, gender, religion	**الحق في الكرامة:** معاملة محترمة بغض النظر عن العرق، الجنس، الدين
3	**Right to Privacy:** Confidential information, private examinations	**الحق في الخصوصية:** معلومات سرية، فحوصات خاصة
4	**Right to Information:** Access to medical records, diagnosis, prognosis	**الحق في المعلومات:** الوصول للسجلات الطبية، التشخيص، التوقعات
5	**Right to Informed Consent:** Full understanding before any procedure	**الحق في الموافقة المستنيرة:** فهم كامل قبل أي إجراء
6	**Right to Refuse Treatment:** Even life-saving care (with documentation)	**الحق في رفض العلاج:** حتى العلاج المنقذ للحياة (مع التوثيق)
7	**Right to Second Opinion:** Consult another physician	**الحق في رأي ثاني:** استشارة طبيب آخر
8	**Right to Complain:** Voice concerns without fear of retaliation	**الحق في الشكوى:** إبداء المخاوف بدون خوف من الانتقام
9	**Right to Pain Management:** Adequate pain control	**الحق في إدارة الألم:** تحكم كافٍ في الألم
10	**Right to End-of-Life Care:** Dignified death, DNR, palliative care	**الحق في رعاية نهاية الحياة:** موت كريم، DNR، رعاية تلطيفية

⚠ **Special Groups:** Children, unconscious patients, and mentally impaired need special protection. Involve legal guardians.

⚠ **فئات خاصة:** الأطفال، فاقدو الوعي، والمعاقون عقلياً يحتاجون حماية خاصة. اشمل الأولياء القانونيين.

ℹ **Cultural Sensitivity:** Rights are universal, but respect cultural differences in family involvement, gender preferences, etc.

ℹ **الحساسية الثقافية:** الحقوق عالمية، لكن احترم الاختلافات الثقافية في مشاركة العائلة، تفضيلات الجنس، إلخ.

 Nurse's Role: Advocate for your patient! You are their voice when they cannot speak for themselves.

 دور الممرض: ادافع عن مريضك! أنت صوته لما ما يقدرش يتكلم عن نفسه.

Source: WHO Patient Rights Charter • JCI Patient Rights Standards • Egyptian MOH Patient Rights.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

✍ Legal & Ethical Requirement / متطلب قانوني وأخلاقي

Definition: Informed Consent is a **voluntary agreement** by the patient (or authorized representative) after receiving full information about the procedure, risks, benefits, and alternatives.

التعريف: الموافقة المستنيرة هي **موافقة طوعية** من المريض (أو ممثله المخوّل) بعد استلام معلومات كاملة عن الإجراء، المخاطر، الفوائد، والبدائل.

4 Elements of Valid Consent / 4 عناصر للموافقة الصحيحة

1	**CAPACITY** Patient must be mentally competent to understand and decide (age ≥ 18, alert, oriented).	**الأهلية** المريض يجب أن يكون **عقلياً** قادر على الفهم والقرار (العمر ≥ 18، واعٍ، مدرك).
2	**DISCLOSURE** Full information: what, why, risks, benefits, alternatives, consequences of refusal.	**الإفصاح** معلومات كاملة: ماذا، لماذا، المخاطر، الفوائد، البدائل، عواقب الرفض.
3	**UNDERSTANDING** Patient must UNDERSTAND (not just hear). Use plain language, teach-back method.	**الفهم** المريض يجب أن **يفهم** (ليس فقط يسمع). استخدم لغة بسيطة، طريقة teach-back.
4	**VOLUNTARY** Free from coercion, pressure, or manipulation. Patient chooses freely.	**طوعية** خالية من الإكراه، الضغط، أو التلاعب. المريض يختار بحرية.

Types of Consent / أنواع الموافقة

Written: For surgery, invasive procedures, research (documented)	**مكتوبة:** للجراحة، الإجراءات الاختراقية، الأبحاث (موثقة)
Verbal: For minor procedures (documented in chart)	**شفهية:** للإجراءات البسيطة (موثقة بالملف)
Implied: Patient extends arm for BP measurement	**ضمنية:** المريض يمد ذراعه لقياس الضغط
Emergency Exception: Life-saving care without consent if unconscious	**استثناء الطوارئ:** رعاية منقذة للحياة بدون موافقة لو فاقد الوعي

Special Situations / حالات خاصة

1	**Minors (<18):**Parent/legal guardian consents	**القاصرون (<18):**الوالد/الوصي القانوني يوافق
2	**Unconscious:**Next of kin or medical power of attorney	**فاقد الوعي:**أقرب الأقارب أو التوكيل الطبي
3	**Mental Incapacity:**Court-appointed guardian	**الإعاقة العقلية:**وصي معين من المحكمة
4	**Language Barrier:**Certified medical interpreter (not family!)	**حاجز اللغة:**مترجم طبي معتمد (ليس العائلة!)

Nurse's Role: Nurses WITNESS consent (not obtain it). Only the physician can obtain informed consent for procedures!	**دور الممرض:** الممرضون **يشهدون** على الموافقة (لا يأخذونها). فقط الطبيب يأخذ الموافقة المستنيرة للإجراءات!
Right to Withdraw: Patient can withdraw consent at ANY time, even during the procedure!	**الحق في السحب:** المريض يقدر يسحب الموافقة في **أي وقت**، حتى أثناء الإجراء!

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

High-Risk Environments / بيئات عالية الخطورة

ICU (Intensive Care Unit) وحدة العناية المركزة

Safety Priorities:
- Continuous monitoring (HR, BP, SpO2, ETCO2)
- Central line care (CLABSI prevention)
- Ventilator bundles (VAP prevention)
- Sedation vacation daily
- Delirium assessment (CAM-ICU)
- Pressure injury prevention (Q2H turning)

أولويات السلامة:
- مراقبة مستمرة (نبض، ضغط، SpO2)
- رعاية القسطرة المركزية (منع CLABSI)
- حزم جهاز التنفس (منع VAP)
- عطلة تخدير يومية
- تقييم الهذيان (CAM-ICU)
- منع قرح الفراش (تقليب كل ساعتين)

ER (Emergency Room) قسم الطوارئ

Safety Priorities:
- Triage accuracy (ESI 1-5)
- Rapid identification (2 IDs)
- Time-sensitive protocols (STEMI, sepsis, stroke)
- Frequent reassessment
- Overcrowding management
- Handoff between shifts (I-PASS)

أولويات السلامة:
- دقة الفرز (ESI 1-5)
- تعريف سريع (مُعرِّفان)
- بروتوكولات حساسة للوقت (احتشاء، إنتان، سكتة)
- إعادة تقييم متكررة
- إدارة الاكتظاظ
- التسليم بين النوبات (I-PASS)

NICU (Neonatal ICU) وحدة عناية حديثي الولادة

Extra Vigilance:
- Weight-based dosing (mg/kg)
- Small margin of error
- Double-check ALL medications
- Temperature regulation
- Kangaroo care safety
- Prevent infections (immature immunity)

يقظة إضافية:
- جرعات حسب الوزن (مجم/كجم)
- هامش خطأ صغير
- فحص مزدوج **لكل** الأدوية
- تنظيم الحرارة
- سلامة الكنغر
- منع العدوى (مناعة غير ناضجة)

OR (Operating Room) غرفة العمليات

Critical Steps:
- Universal Protocol (IPSG 4)
- Time-Out before incision
- Sponge/instrument counts (Before + After)
- Sterile field maintenance
- Fire safety (electrocautery + O2)
- Anesthesia handoff (PACU)

خطوات حرجة:
- البروتوكول العالمي (IPSG 4)
- Time-Out قبل الشق
- عد الشاش/الأدوات (قبل + بعد)
- الحفاظ على المنطقة المعقمة
- سلامة الحريق (كي كهربائي + O2)
- تسليم التخدير (PACU)

High-Alert Alert: ICU/ER patients are 3-5x more likely to experience an adverse event than regular ward patients!

تنبيه عالي الخطورة: مرضى ICU/ER أكثر عرضة بـ 3-5 مرات لأحداث ضارة من مرضى الأقسام العادية!

Nurse Ratios: ICU = 1:2, ER = 1:3-4, OR = variable. Adequate staffing = better safety outcomes!

نسب الممرضين: ICU = 1:2، ER = 1:3-4، OR = متغيرة. تعيين كافٍ = نتائج سلامة أفضل!

Source: AACN Critical Care Standards • ENA Emergency Standards • AORN OR Guidelines.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

✖ Top 10 Patient Safety Errors That Cost Lives / أخطر 10 أخطاء

Reality: These 10 mistakes account for **90% of preventable patient harm**. Know them, avoid them, save lives!

الواقع: هذه الـ 10 أخطاء تمثل **90% من الأذى القابل للمنع**. اعرفها، تجنبها، أنقذ الأرواح!

1	**Wrong Patient Identification:** Using only 1 identifier or room number.	**تعريف المريض الخطأ:** استخدام مُعرِّف واحد فقط أو رقم الغرفة.
2	**Medication Errors:** Wrong drug, dose, route, time, or patient.	**أخطاء الدواء:** دواء، جرعة، طريق، وقت، أو مريض خطأ.
3	**Poor Communication:** Skipping SBAR or read-back verbal orders.	**سوء التواصل:** تخطي SBAR أو عدم إعادة قراءة الأوامر.
4	**Not Documenting:** "If it's not written, it wasn't done!"	**عدم التوثيق:** "لو ما اتكتبش، ما اتعملش!"
5	**Skipping Hand Hygiene:** #1 cause of HAIs — 5 million deaths/year!	**تخطي نظافة اليدين:** السبب #1 للعدوى — 5 مليون وفاة سنوياً!
6	**No Fall Risk Assessment:** Missing high-risk patients.	**عدم تقييم خطر السقوط:** إغفال المرضى عالي الخطورة.
7	**No Time-Out:** Wrong-site surgery is preventable but STILL happens.	**عدم عمل Time-Out:** جراحة الجانب الخطأ يمكن منعها لكن **لا تزال تحدث**.
8	**Ignoring Alarms:** "Alarm fatigue" kills patients (2,500+ deaths/year).	**تجاهل الإنذارات:** "إجهاد الإنذارات" يقتل المرضى (2,500+ وفاة/سنوياً).
9	**No Second Check:** Not double-checking high-alert medications.	**عدم الفحص المزدوج:** عدم التحقق مرتين من الأدوية عالية الخطورة.
10	**Hierarchy Silence:** Not speaking up when you notice an error.	**الصمت الهرمي:** عدم التحدث عندما تلاحظ خطأ.

🛡 **Prevention:** Use checklists, follow protocols, practice SBAR, speak up! Nurses are the LAST line of defense.

🛡 **الوقاية:** استخدم القوائم، اتبع البروتوكولات، تدرب على SBAR، اتكلم! الممرضين هم **آخر خط دفاع**.

Source: WHO (2021) Patient Safety Report ▪ AHRQ PSNet ▪ Joint Commission Sentinel Events.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🚩 Warning Signs That Something is WRONG / علامات أن هناك مشكلة

Vigilance: Red flags are early warning signs that require IMMEDIATE nursing action. Missing them = potential patient harm or death!

اليقظة: علامات الخطر هي إنذارات مبكرة تتطلب **إجراء تمريضي فوري**. إغفالها = أذى محتمل أو وفاة!

💊 Medication Red Flags / علامات خطر الدواء

1	**Unusual Dose:**	"Give 100 units insulin" (usually 10-40 units) — VERIFY!	**جرعة غير عادية:**	"أعطي 100 وحدة إنسولين" (عادةً 10-40) — **تحقق**!
2	**New Allergy:**	Patient develops rash after new medication — STOP!	**حساسية جديدة:**	المريض عنده طفح جلدي بعد دواء جديد — **توقف**!
3	**Look-Alike Drugs:**	Hydralazine vs Hydroxyzine — double-check name!	**أدوية متشابهة:**	Hydralazine vs Hydroxyzine — افحص الاسم مرتين!

🏥 Clinical Red Flags / علامات خطر إكلينيكية

1	**Sudden Change in LOC:**	Confusion, agitation, or lethargy — NEURO check!	**تغير مفاجئ في الوعي:**	ارتباك، هياج، أو خمول — **فحص عصبي**!
2	**Rapid Vitals Change:**	HR >120 or <50, BP drop >20 mmHg, SpO2 <90%.	**تغير سريع في العلامات:**	نبض >120 أو <50، ضغط ينخفض >20، تشبع <90%.
3	**Chest Pain:**	New onset chest pain — ECG + physician NOW!	**ألم صدر:**	ألم صدر جديد — **تخطيط قلب + طبيب فوراً**!
4	**Respiratory Distress:**	RR >30, accessory muscles, cyanosis.	**ضيق تنفس:**	معدل تنفس >30، استخدام عضلات، زرقة.
5	**Decreased Urine Output:**	<30 mL/hr — check kidney/hydration!	**انخفاض البول:**	<30 مل/ساعة — افحص الكلى/الترطيب!

🆘 Emergency Red Flags (RRT Activation!) / علامات طارئة

🚨 **Activate Rapid Response Team (RRT) if:** Sudden mental status change ▪ RR <8 or >28 ▪ HR <40 or >140 ▪ SBP <90 ▪ SpO2 <90% on O2 ▪ New chest pain ▪ Nurse's "gut feeling" — TRUST IT!

🚨 **فعّل فريق الاستجابة السريعة (RRT) في:** تغير مفاجئ للوعي ▪ تنفس <8 أو >28 ▪ نبض <40 أو >140 ▪ ضغط <90 ▪ تشبع <90% مع أكسجين ▪ ألم صدر جديد ▪ حدس الممرض — **ثق فيه**!

⚠ **Documentation Red Flags:** Missing signatures, unclear orders, contradicting notes, missing vitals.

⚠ **علامات خطر التوثيق:** توقيعات ناقصة، أوامر غير واضحة، ملاحظات متناقضة، علامات مفقودة.

🗣 **SPEAK UP:** If something feels wrong, use CUS: **C**oncerned + **U**ncomfortable + **S**afety issue!

🗣 **اتكلم:** لو حسّيت إن فيه حاجة غلط، استخدم CUS: **قلقان** + **مش مرتاح** + **مشكلة أمان**!

Source: IHI Rapid Response Teams ▪ MEWS Score ▪ TeamSTEPPS CUS Tool.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Vulnerable Populations Need Extra Protection / الفئات الضعيفة تحتاج حماية إضافية

Pediatric Safety (Neonates & Children) سلامة الأطفال وحديثي الولادة

Key Risks:
- Weight-based dosing errors (10x overdose!)
- Difficulty in identification (name only)
- Communication challenges
- Higher fall risk (crib rails)

Safety Actions:
- Double-check ALL doses
- Use color-coded wristbands
- Involve parents in identification
- Small-volume IV bags for infants

المخاطر الرئيسية:
- أخطاء جرعات حسب الوزن (10x جرعة زائدة!)
- صعوبة التعريف (بالاسم فقط)
- تحديات التواصل
- خطر سقوط عالٍ (حواجز السرير)

إجراءات السلامة:
- فحص مزدوج **لكل** الجرعات
- أساور ملونة حسب الحالة
- إشراك الأهل في التعريف
- أكياس IV صغيرة للرضع

Elderly Safety (>65 years) سلامة كبار السن (>65 سنة)

Key Risks:
- Polypharmacy (5+ medications)
- Falls (33% risk in hospital)
- Delirium (30% of hospitalized)
- Pressure injuries
- Beers Criteria drugs (avoid list)

Safety Actions:
- Medication reconciliation
- Morse Fall Scale assessment
- CAM screening for delirium
- Braden Scale (pressure risk)

المخاطر الرئيسية:
- تعدد الأدوية (5+ أدوية)
- السقوط (خطر 33% في المستشفى)
- الهذيان (30% من المنومين)
- قرح الفراش
- أدوية معايير Beers (قائمة تجنب)

إجراءات السلامة:
- توفيق الأدوية
- تقييم مقياس Morse للسقوط
- فحص CAM للهذيان
- مقياس Braden (خطر القرح)

Pregnant Patients المريضات الحوامل

Key Risks:
- Teratogenic medications
- Radiation exposure
- DVT risk (higher during pregnancy)
- Hypertension monitoring

Safety Actions:
- Check pregnancy category (A/B/C/D/X)
- Shield abdomen during X-rays
- DVT prophylaxis if bedridden
- Frequent BP checks (preeclampsia!)

المخاطر الرئيسية:
- أدوية مشوهة للجنين
- التعرض للإشعاع
- خطر جلطة الأوردة (أعلى بالحمل)
- متابعة ضغط الدم

إجراءات السلامة:
- افحص فئة الحمل (A/B/C/D/X)
- احمي البطن أثناء الأشعة
- وقاية DVT للممددات
- فحص ضغط متكرر (تسمم الحمل!)

⚠ **Pediatric Alert:** 3x more medication errors in children due to weight-based dosing complexity!

⚠ **تنبيه الأطفال:** أخطاء الدواء في الأطفال أعلى 3 مرات بسبب تعقيد الجرعات حسب الوزن!

Golden Rule: "The younger or older the patient, the more careful you must be!"

القاعدة الذهبية: "كل ما المريض أصغر أو أكبر، كل ما تحتاج تكون أكثر حذراً!"

Source: AAP Pediatric Safety • Beers Criteria (2023) • ACOG Pregnancy Guidelines.

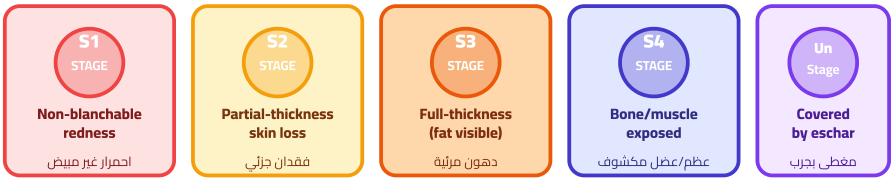
RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🩹 Preventing Bed Sores / منع قرح الفراش

Definition: Pressure injuries (bed sores) are localized damage to skin/tissues due to prolonged pressure. They affect **2.5 million patients/year** in the US and cost $26 billion!

التعريف: قرح الفراش هي تلف موضعي في الجلد/الأنسجة بسبب الضغط الطويل. تصيب **2.5 مليون مريض سنوياً** في أمريكا وتكلف 26 مليار دولار!

🖼️ Pressure Injury Stages / مراحل قرح الفراش



📊 Braden Scale (Risk Assessment) / مقياس Braden لتقييم الخطر

Score Range: 6-23 (lower = higher risk)	**نطاق النتيجة:** 6-23 (الأقل = خطر أعلى)
≤9: Very high risk (severe)	**≤9:** خطر عالٍ جداً (شديد)
10-12: High risk	**10-12:** خطر عالٍ
13-14: Moderate risk	**13-14:** خطر متوسط
15-18: Mild risk	**15-18:** خطر بسيط

🛡️ Prevention Interventions / تدخلات الوقاية

1	**Turn Every 2 Hours:** Reposition to relieve pressure points.	**تقليب كل ساعتين:** إعادة الوضع لتخفيف نقاط الضغط.
2	**Pressure Redistribution:** Special mattresses, heel protectors.	**إعادة توزيع الضغط:** مراتب خاصة، حماية الكعب.
3	**Skin Assessment:** Daily inspection of bony prominences.	**تقييم الجلد:** فحص يومي للنتوءات العظمية.
4	**Nutrition Support:** Protein-rich diet, adequate hydration.	**دعم التغذية:** نظام غني بالبروتين، ترطيب كافٍ.
5	**Moisture Management:** Keep skin clean and dry.	**إدارة الرطوبة:** الحفاظ على الجلد نظيف وجاف.

⚠️ **Never Event:** Stage 3 or 4 hospital-acquired pressure injuries are considered "Never Events" — must NEVER happen!	⚠️ **حدث لا يجب حدوثه:** قرح فراش مرحلة 3-4 مكتسبة من المستشفى تعتبر "أحداث لا يجب حدوثها" — يجب **ألا تحدث أبداً**!

Source: NPIAP (2019) Pressure Injury Guidelines • Braden Scale • AHRQ Pressure Ulcer Prevention.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

⚠ Last Resort Only! / الملاذ الأخير فقط!

Definition: Restraints are devices/methods that restrict patient movement. They are ONLY used as a **LAST RESORT** to prevent immediate harm when all alternatives have failed.

التعريف: التقييد هو أجهزة/طرق تقيد حركة المريض. يُستخدم **فقط** كـ **ملاذ أخير** لمنع أذى فوري عندما تفشل كل البدائل.

🔒 Types of Restraints / أنواع التقييد

1	**Physical:**Wrist/ankle straps, mittens, vest restraints.	**جسدي:**أشرطة معصم/كاحل، قفازات، صدرية تقييد.
2	**Chemical:**Medications (Haloperidol, Lorazepam) to sedate.	**كيميائي:**أدوية (Haloperidol, Lorazepam) للتهدئة.
3	**Environmental:**Locked doors, bed alarms (technically restraint).	**بيئي:**أبواب مقفلة، أجهزة إنذار السرير (تُعتبر تقييد فنياً).

✓ Alternatives to Try FIRST / بدائل يجب تجربتها أولاً

1. Verbal De-escalation: Calm voice, empathy	**1. التهدئة اللفظية:** صوت هادئ، تعاطف
2. Sitter (1:1 supervision): Constant observation	**2. مرافق (1:1):** مراقبة مستمرة
3. Family Presence: Familiar face calms agitation	**3. حضور الأهل:** وجه مألوف يهدئ الهياج
4. Toileting: Address unmet needs	**4. الحمام:** تلبية الاحتياجات
5. Pain Control: Uncontrolled pain causes agitation	**5. تحكم الألم:** ألم غير مسيطر يسبب الهياج
6. Environmental: Reduce noise, dim lights	**6. بيئي:** تقليل الضجيج، إضاءة خافتة

📋 Restraint Rules (JCI Standards) / قواعد التقييد

1	**Physician Order:**Required within 1 hour of application.	**أمر طبيب:**مطلوب خلال ساعة من التطبيق.
2	**Time Limits:**Adults 4 hrs, Adolescents 2 hrs, Children 1 hr.	**حدود زمنية:**بالغين 4 ساعات، مراهقين 2، أطفال 1.
3	**Assessment Every 15 min:**Circulation, skin, ROM.	**تقييم كل 15 دقيقة:**دورة دموية، جلد، حركة.
4	**Release Every 2 hrs:**Skin check, ROM exercises, toileting.	**فك كل ساعتين:**فحص جلد، تمارين حركة، حمام.
5	**Quick-Release Knot:** Use knot that can be released in emergency.	**عقدة فك سريع:**استخدم عقدة يمكن فكها بسرعة في الطوارئ.

⚠ **Complications:** Strangulation, asphyxiation, nerve damage, DVT, pressure injuries, PTSD, DEATH!	⚠ **المضاعفات:** اختناق، تلف أعصاب، جلطات، قرح فراش، اضطراب ما بعد الصدمة، **الوفاة**!
⚠ **Golden Rule:** "The least restrictive method for the shortest time possible." Document everything!	⚠ **القاعدة الذهبية:** "أقل طريقة تقييد لأقصر وقت ممكن" وثّق كل شيء!

Source: JCI Restraint Standards • CMS Regulations • APNA Position Statement.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

33 — Clinical Case Scenarios حالات إكلينيكية

Real-Life Cases to Learn From / حالات واقعية للتعلم منها

CASE 1 — Wrong Patient Medication

Scenario: Nurse gives Warfarin 5mg to "Mr. Ahmed" in bed 3. Later discovers there are TWO patients named Ahmed in the ward, and she gave it to the wrong one!

السيناريو: ممرضة أعطت وارفارين 5mg لـ "السيد أحمد" في سرير 3. اكتشفت بعدين إن فيه اتنين اسمهم أحمد في القسم، وأعطته للغلط!

✓ **Right Action:** Notify physician immediately + assess for bleeding + document + incident report. **Prevention:** Always use 2 identifiers (name + DOB).

✓ **الإجراء الصحيح:** بلّغ الطبيب فوراً + قيّم النزيف + وثّق + تقرير حادث. **الوقاية:** استخدم دايماً مُعرِّفين (اسم + تاريخ ميلاد).

CASE 2 — Near Miss: KCl

Scenario: Nurse about to give concentrated KCl (20 mEq) IV push instead of diluted infusion. Colleague catches her BEFORE the injection. Patient safe!

السيناريو: ممرضة كانت هتعطي KCl مركز (20 mEq) push بدل التنقيط. الزميلة أوقفتها **قبل** الحقن. المريض سليم!

✓ **Right Action:** Report as "Near Miss" — still requires incident report. Analyze WHY it almost happened to prevent future errors.

✓ **الإجراء الصحيح:** بلّغ كـ "حادث وشيك" — يحتاج تقرير حادث. حلل **ليه** كان قرب يحصل لمنع الأخطاء المستقبلية.

CASE 3 — Wrong-Site Surgery

Scenario: Surgeon starts operating on RIGHT knee but consent says LEFT. Circulating nurse notices the discrepancy after the incision is made.

السيناريو: جراح بدأ عملية في الركبة **اليمنى** بس الموافقة تقول **اليسرى**. الممرضة الجوالة لاحظت الفرق بعد الشق!

✓ **Right Action:** STOP surgery immediately + notify all + document + inform patient/family (disclosure) + sentinel event report + RCA.

✓ **الإجراء الصحيح:** أوقف الجراحة فوراً + بلّغ الجميع + وثّق + أبلغ المريض/الأسرة + تقرير حدث خطير + تحليل السبب الجذري.

CASE 4 — Fall Prevention Failure

Scenario: 78-year-old patient with Morse score 65 (high risk) tries to walk to bathroom alone at 3 AM. Falls and fractures hip. No bed alarm was activated.

السيناريو: مريض 78 سنة بنقاط Morse 65 (خطر عالي) حاول يمشي للحمام لوحده الساعة 3 صباحاً. سقط وكسر الفخذ. جهاز الإنذار كان مطفي!

✓ **Right Action:** Do NOT move patient + assess vitals + notify physician + document + fall event report. **Prevention:** Activate bed alarms for ALL high-risk patients!

✓ **الإجراء الصحيح: ممنوع** تحريكه + قيّم العلامات + بلّغ الطبيب + وثّق + تقرير سقوط. **الوقاية:** فعّل أجهزة الإنذار **لكل** مرضى الخطر العالي!

Learning: Every case is a learning opportunity. Discuss cases in team meetings — prevent future errors!

التعلم: كل حالة فرصة للتعلم. ناقش الحالات في اجتماعات الفريق — امنع الأخطاء المستقبلية!

Source: Adapted from AHRQ WebM&M Cases ▪ Joint Commission Sentinel Event Alerts.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Wisdom from 6 Years of ICU Experience / حكمة من 6 سنين خبرة ICU

Personal Note from Ali Ashour, RN: These pearls are lessons I learned the hard way. They will make you a SAFER, WISER nurse!

ملاحظة شخصية من علي عاشور: اللآلئ دي دروس اتعلمتها بصعوبة. هيخلوك ممرض **أكثر أماناً وحكمة**!

	Pearl 1: Trust your gut. If something "feels" wrong with your patient — investigate! Nurse intuition is REAL and evidence-backed.	**لؤلؤة 1:** ثق في حدسك. لو حسّيت إن فيه حاجة "غلط" مع مريضك — حقق! حدس الممرض **حقيقي** ومدعوم علمياً.
	Pearl 2: The #1 way to prevent errors is to SLOW DOWN. Rushing = mistakes. Take an extra 10 seconds to double-check.	**لؤلؤة 2:** أهم طريقة لمنع الأخطاء هي **البطء**. الاستعجال = أخطاء. خذ 10 ثواني إضافية للفحص المزدوج.
	Pearl 3: ALWAYS check 2 identifiers before ANY intervention. Name + DOB. Every time. No exceptions.	**لؤلؤة 3: دائماً** افحص مُعرِّفين قبل **أي** تدخل. اسم + تاريخ ميلاد. كل مرة. بدون استثناء.
	Pearl 4: If you don't know a drug — STOP and look it up! Never give a medication you're unsure about.	**لؤلؤة 4:** لو ما تعرفش دواء — **توقف** وابحث عنه! ممنوع تعطي دواء إنت مش متأكد منه.
	Pearl 5: Report ALL near-misses, not just actual errors. They reveal system weaknesses!	**لؤلؤة 5:** بلّغ عن **كل** الحوادث الوشيكة، مش بس الأخطاء الفعلية. هي بتكشف ضعف الأنظمة!
	Pearl 6: Speak up! Don't stay silent if you notice an error, even if the doctor is senior. Patient safety trumps hierarchy!	**لؤلؤة 6: اتكلم**! ماتسكتش لو لاحظت خطأ، حتى لو الدكتور كبير. سلامة المريض **أهم** من الهرمية!
	Pearl 7: Sleep matters! Fatigue causes 30% more errors. Get 7-8 hours before shifts — your patients depend on it.	**لؤلؤة 7:** النوم مهم! الإرهاق يسبب 30% أخطاء أكثر. نام 7-8 ساعات قبل النوبات — مرضاك يعتمدون عليك.
	Pearl 8: Documentation protects patients AND nurses. Write clearly, timely, and completely. "Not documented = not done!"	**لؤلؤة 8:** التوثيق يحمي المرضى **والممرضين**. اكتب بوضوح، بسرعة، وبالكامل. "لو ما اتوثقش = ما اتعملش!"
	Pearl 9: Use technology wisely: barcode scanners, smart pumps, EMR alerts. They catch errors humans miss!	**لؤلؤة 9:** استخدم التكنولوجيا بذكاء: قارئات الباركود، المضخات الذكية، تنبيهات EMR. بتكشف أخطاء البشر بتفوتها!
	Pearl 10: Take care of yourself. A burned-out nurse is a dangerous nurse. Self-care = patient safety!	**لؤلؤة 10:** اهتم بنفسك. الممرض المرهق ممرض خطر. الرعاية الذاتية = سلامة المريض!
	Ali's Golden Advice: "Every shift, ask yourself: 'What could go wrong today, and how can I prevent it?' Prevention is EVERYTHING."	**نصيحة علي الذهبية:** "كل نوبة، اسأل نفسك: 'إيه اللي ممكن يحصل غلط النهاردة، وإزاي أمنعه؟' الوقاية **كل شيء**"

Source: Personal Clinical Experience ▪ RN Ali Ashour, BSN ▪ NurseHub Egypt © 2025.

📊 Measuring Patient Safety Performance / قياس أداء سلامة المريض

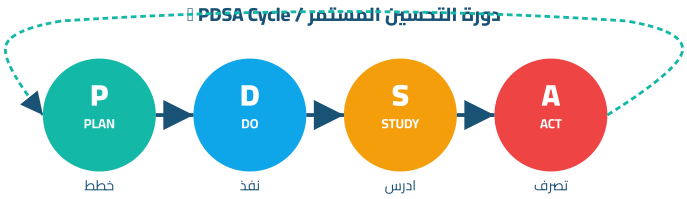
Concept: "You can't improve what you don't measure!" Compliance monitoring tracks safety practices to identify gaps and drive improvement.

الفكرة: "لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه!" مراقبة الالتزام تتبع ممارسات السلامة لتحديد الفجوات وتحفيز التحسين.

📈 Key Safety Metrics / مؤشرات السلامة الرئيسية

Metric / المؤشر	Target / الهدف	Frequency / التكرار
Hand Hygiene Compliance	≥95%	Daily
Patient ID Verification (2 identifiers)	100%	Every task
Medication Error Rate	<1%	Monthly
Fall Rate (per 1000 patient days)	<3.5	Monthly
CLABSI Rate	<1 per 1000 line days	Monthly
CAUTI Rate	<1.5 per 1000 catheter days	Monthly
Pressure Injury Prevalence	<3%	Quarterly
Time-Out Compliance	100%	Every surgery
SBAR Handoff Compliance	≥90%	Every shift
Incident Report Submission	>80% within 24h	Continuous

🔄 Continuous Quality Improvement (PDSA Cycle) / دورة PDSA



ℹ Audit Tools: Direct observation, chart review, incident reports, patient surveys, staff feedback surveys.

ℹ أدوات التدقيق: ملاحظة مباشرة، مراجعة السجلات، تقارير الحوادث، استبيانات المرضى، استبيانات الطاقم.

🔑 Culture Point: Monitoring is NOT policing! It's about learning and improving. Celebrate wins, address gaps together.

🔑 نقطة ثقافية: المراقبة **ليست** مراقبة أمنية! هي عن التعلم والتحسين. احتفل بالنجاحات، عالج الفجوات معاً.

Source: IHI PDSA Model • JCI Quality Metrics • AHRQ Safety Culture Assessment.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

⚡ Quick Reference for Emergency Situations / مرجع سريع لحالات الطوارئ

🆔 IPSG 1: Identify Patient

✓ Use 2 identifiers
✓ Name + Date of Birth
✗ NEVER use room number!

✓ استخدم مُعرِّفين
✓ الاسم + تاريخ الميلاد
✗ ممنوع رقم الغرفة!

🗣️ IPSG 2: SBAR

S = Situation
B = Background
A = Assessment
R = Recommendation

S = الموقف
B = الخلفية
A = التقييم
R = التوصية

💊 IPSG 3: High-Alert Meds

Insulin, Heparin, Warfarin, KCl, Opioids, Chemo
✓ Double-check!

إنسولين، هيبارين، وارفارين، KCl، مسكنات، كيماوي
✓ فحص مزدوج!

✅ IPSG 4: Time-Out

Right Patient +
Right Procedure +
Right Site

المريض الصحيح +
الإجراء الصحيح +
الموضع الصحيح

🧼 IPSG 5: Hand Hygiene

5 WHO Moments:
Before touch, Before aseptic, After fluid, After touch, After surround.

5 لحظات WHO:
قبل اللمس، قبل التعقيم، بعد السوائل، بعد اللمس، بعد البيئة

🚶 IPSG 6: Fall Prevention

Morse Scale ≥51 = HIGH RISK
Yellow band + Bed alarm + Non-slip socks

Morse ≥51 = خطر عالي
سوار أصفر + إنذار سرير + جوارب مانعة

💉 5 Rights (Medications)

1. Right Patient
2. Right Drug
3. Right Dose
4. Right Route
5. Right Time

1. المريض
2. الدواء
3. الجرعة
4. الطريق
5. الوقت

🚨 RRT Activation

HR<40 or >140
SBP<90
SpO2<90%
New confusion
Nurse gut feeling!

نبض <40 أو >140
ضغط <90
تشبع <90%
ارتباك جديد
حدس الممرض!

📌 **Save This Page!** Print it, keep it in your pocket, review before every shift!

📌 **احفظ الصفحة دي!** اطبعها، خليها في جيبك، راجعها قبل كل نوبة!

Source: Compiled from JCI (2023), WHO (2020), and clinical experience.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

✅ Practical Exam Assessment / تقييم الامتحان العملي

🏥 Patient Safety OSCE Station

Maximum Score: 20 points | الدرجة القصوى: 20 نقطة

Part A: Patient Identification & Communication (10 points)

1	Introduces self & states purpose (name, role)	يعرّف نفسه ويوضح الغرض (اسم، دور)	/ 1
2	Verifies patient using 2 identifiers (Name + DOB)	يتحقق من المريض بمُعرِّفين (اسم + تاريخ ميلاد)	/ 2
3	Checks patient wristband against orders	يفحص سوار المريض مع الأوامر	/ 1
4	Performs hand hygiene (WHO 5 Moments)	يعمل نظافة اليدين (لحظات WHO الخمس)	/ 2
5	Uses SBAR to communicate with physician	يستخدم SBAR في التواصل مع الطبيب	/ 2
6	Documents interaction accurately and timely	يوثق التعامل بدقة وسرعة	/ 2

Part B: Safety Interventions (10 points)

7	Applies the 5 Rights of medication administration	يطبق الحقوق الخمسة لإعطاء الأدوية	/ 2
8	Performs Morse Fall Risk Assessment	يجري تقييم Morse لخطر السقوط	/ 2
9	Implements fall prevention interventions	يطبق تدخلات الوقاية من السقوط	/ 2
10	Explains procedure to patient (informed consent)	يشرح الإجراء للمريض (الموافقة المستنيرة)	/ 2
11	Identifies safety red flags & escalates appropriately	يحدد علامات الخطر ويصعّد بشكل مناسب	/ 2

⚠ **Critical Failure Points (Instant Fail):** Not verifying patient ID ▪ Skipping hand hygiene ▪ No documentation ▪ Ignoring red flags	⚠ **نقاط الفشل الحرجة (رسوب فوري):** عدم التحقق من هوية المريض ▪ تخطي نظافة اليدين ▪ عدم التوثيق ▪ تجاهل علامات الخطر

Source: Standard OSCE Rubric ▪ Egyptian Nursing Council ▪ JCI Assessment Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

38 — OSCE Examiner Tips | نصائح ممتحن OSCE

What Examiners Look For / ما يبحث عنه الممتحنون

Insider Info: OSCE examiners follow strict rubrics. Verbalize every step, follow protocols, and NEVER skip safety checks!

معلومة داخلية: ممتحنو OSCE يتبعون معايير صارمة. اشرح كل خطوة، اتبع البروتوكولات، و**ماتخطش أبداً** فحوصات السلامة!

1	**Verbalize Everything:** "I am now verifying the patient with 2 identifiers..."	**اشرح كل شيء:** "أنا الآن أتحقق من المريض بمُعرِّفين.."
2	**Show Rationale:** "I check 2 identifiers to prevent wrong-patient errors."	**اظهر المنطق:** "أفحص مُعرِّفين لمنع أخطاء تحديد المريض الخطأ"
3	**Use Standard Tools:** Morse Scale, Braden Scale, SBAR — mention them by name!	**استخدم أدوات قياسية:** Morse Scale, Braden Scale, SBAR — اذكرها بأسمائها!
4	**Follow Safety Checks:** Never skip Time-Out, medication verification, or hand hygiene.	**اتبع فحوصات السلامة:** ماتخطش أبداً Time-Out، فحص الدواء، أو نظافة اليدين.
5	**Speak Up:** If you see an error in scenario, speak up! Examiners test this.	**اتكلم:** لو شفت خطأ في السيناريو، **اتكلم**! الممتحنين يختبروا هذا.
6	**Document Time:** "I document at 14:30, using timely and complete entries."	**وثّق الوقت:** "أوثق في 14:30، باستخدام إدخالات في الوقت المناسب وكاملة"

⚠ Common Reasons for OSCE Failure / أسباب فشل OSCE الشائعة

✖ **Skipping patient identification** (auto-fail!)	✖ **تخطي تعريف المريض** (رسوب تلقائي!)
✖ **Not verbalizing** steps & rationale	✖ **عدم شرح** الخطوات والمنطق
✖ **Poor SBAR structure** in communication	✖ **هيكل SBAR ضعيف** في التواصل
✖ **Not using** assessment tools by name	✖ **عدم استخدام** أدوات التقييم بالاسم
✖ **Ignoring red flags** in scenario	✖ **تجاهل علامات الخطر** في السيناريو
✖ **Not documenting** at end	✖ **عدم التوثيق** في النهاية

Pro Tip: Practice with a partner. Rehearse SBAR, Morse Scale, and safety scenarios 20+ times before exam!

نصيحة احترافية: تدرب مع شريك. تمرن على SBAR Morse Scaleg وسيناريوهات السلامة 20+ مرة قبل الامتحان!

Passing Score: 70% (14/20). Aim for 90%+ with consistent practice!

درجة النجاح: 70% (14/20). اهدف لـ 90%+ مع الممارسة المستمرة!

Source: Egyptian Nursing Council OSCE Guidelines • NCSBN OSCE Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🧠 **Powerful Memory Tricks / حيل قوية للحفظ**

ICEMIF

6 IPSG Goals: **I**dentify patients + **C**ommunicate effectively + **E**xtra-safe meds + **M**ark surgery + **I**nfection prevention + **F**all reduction

أهداف السلامة الست: تعريف + تواصل + أدوية آمنة + تعليم جراحة + منع عدوى + تقليل السقوط

SBAR

Communication: **S**ituation + **B**ackground + **A**ssessment + **R**ecommendation

التواصل: الموقف + الخلفية + التقييم + التوصية

5 RIGHTS

Medication Safety: Right **P**atient + Right **D**rug + Right **D**ose + Right **R**oute + Right **T**ime

سلامة الدواء: المريض + الدواء + الجرعة + الطريق + الوقت

CUS

Speak Up: "I am **C**oncerned + I am **U**ncomfortable + This is a **S**afety issue!"

اتكلم: "أنا قلقان + أنا مش مرتاح + دي مشكلة أمان!"

PDSA

Quality Improvement: **P**lan + **D**o + **S**tudy + **A**ct (continuous cycle)

تحسين الجودة: خطط + نفذ + ادرس + تصرف (دورة مستمرة)

RRT

Rapid Response Criteria: **R**espiratory rate abnormal + **R**apid HR change + **T**rouble breathing/BP drop

معايير الاستجابة السريعة: تنفس غير طبيعي + تغير نبض سريع + مشكلة تنفس/انخفاض ضغط

WHO 5

Hand Hygiene Moments: Before Touch + Before Aseptic + After Fluid + After Touch + After Surroundings

لحظات نظافة اليدين: قبل اللمس + قبل التعقيم + بعد السوائل + بعد اللمس + بعد البيئة

TIME-OUT

Before Surgery: **T**eam pauses + **I**dentify patient + **M**ark site + **E**quipment ready + **O**rder verified + **U**nique needs + **T**ime documented

قبل الجراحة: الفريق يتوقف + هوية المريض + تعليم الموضع + المعدات + الأمر + احتياجات + توثيق الوقت

💡 **Study Tip:** Write these mnemonics on flashcards. Test yourself daily — they'll save you in exams AND clinical practice!

💡 **نصيحة للدراسة:** اكتب هذه الحيل على بطاقات. اختبر نفسك يومياً — هيساعدوك في الامتحانات **والممارسة الإكلينيكية**!

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

40 — MCQs (Part 1: Q1-Q5) أسئلة اختيار من متعدد (1)

Test Your Knowledge / اختبر معلوماتك

Q1

The MINIMUM number of identifiers required to verify a patient is:

أقل عدد من المُعرّفات للتحقق من المريض هو:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

أ) 1
ب) 2
ج) 3
د) 4

✓ **Answer: b) 2 (Name + DOB)**

✓ **الإجابة: ب) 2 (اسم + تاريخ ميلاد)**

Q2

According to WHO, medical errors are the ___ leading cause of death in the USA:

حسب WHO، الأخطاء الطبية هي السبب الـ ___ للوفاة في أمريكا:

a) 1st
b) 2nd
c) 3rd
d) 5th

أ) 1
ب) 2
ج) 3
د) 5

✓ **Answer: c) 3rd (after heart disease & cancer)**

✓ **الإجابة: ج) 3 (بعد القلب والسرطان)**

Q3

Which is the CORRECT SBAR order?

ما هو الترتيب الصحيح لـ SBAR؟

a) Assessment, Background, Situation, Recommendation
b) Situation, Background, Assessment, Recommendation
c) Background, Situation, Recommendation, Assessment
d) Recommendation, Situation, Assessment, Background

أ) تقييم، خلفية، موقف، توصية
ب) موقف، خلفية، تقييم، توصية
ج) خلفية، موقف، توصية، تقييم
د) توصية، موقف، تقييم، خلفية

✓ **Answer: b) S-B-A-R**

✓ **الإجابة: ب) S-B-A-R**

Q4

A Morse Fall Scale score of 55 indicates:

نتيجة Morse Fall Scale = 55 تعني:

a) Low risk
b) No risk
c) Moderate risk
d) High risk

أ) خطر منخفض
ب) لا خطر
ج) خطر متوسط
د) خطر عالي

✓ **Answer: d) High risk (≥51)**

✓ **الإجابة: د) خطر عالي (≥51)**

Q5

Which is NOT one of the "5 Rights" of medication administration?

أي من التالي ليس من "الحقوق الخمسة" للدواء؟

a) Right Patient
b) Right Dose
c) Right Doctor
d) Right Route

أ) المريض
ب) الجرعة
ج) الطبيب
د) الطريق

✓ **Answer: c) Right Doctor (not a Right)**

✓ **الإجابة: ج) الطبيب (ليس من الحقوق)**

Source: NCLEX-style questions • Egyptian Nursing Council MCQs.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

41 — MCQs (Part 2: Q6-Q8) أسئلة اختيار من متعدد (2)

📝 More MCQs / المزيد من الأسئلة

Q6

A "Never Event" refers to:

"حدث لا يجب حدوثه" يشير إلى:

a) A minor error
b) A serious preventable event that should never happen
c) Any adverse event
d) A near-miss event

أ) خطأ بسيط
ب) حدث خطير يمكن منعه ويجب ألا يحدث أبداً
ج) أي حدث ضار
د) حدث وشيك

✓ **Answer: b) Serious preventable event**

✓ **الإجابة: ب) حدث خطير قابل للمنع**

Q7

The Swiss Cheese Model explains that errors occur when:

نموذج الجبنة السويسرية يوضح أن الأخطاء تحدث عندما:

a) One person makes a mistake
b) Holes in multiple layers align
c) There's no policy
d) A single error occurs

أ) شخص واحد يخطئ
ب) الثقوب في طبقات متعددة تتراص
ج) لا توجد سياسة
د) خطأ واحد يحدث

✓ **Answer: b) Holes align across layers**

✓ **الإجابة: ب) الثقوب تتراص عبر الطبقات**

Q8

Concentrated Potassium Chloride (KCl) should be stored:

كلوريد البوتاسيوم المركز (KCl) يجب تخزينه في:

a) Nursing station
b) Patient room
c) Pharmacy ONLY
d) Medication cart

أ) محطة التمريض
ب) غرفة المريض
ج) الصيدلية **فقط**
د) عربة الأدوية

✓ **Answer: c) Pharmacy ONLY (safety rule!)**

✓ **الإجابة: ج) الصيدلية فقط (قاعدة سلامة!)**

💡 **Study Tip:** Review MCQs daily. Understand WHY each answer is correct, not just memorize!

💡 **نصيحة للدراسة:** راجع الأسئلة يومياً. افهم **لماذا** الإجابة صحيحة، مش مجرد حفظ!

ℹ **Next Page:** True/False questions + Fill in the Blanks exercises for extra practice.

ℹ **الصفحة القادمة:** أسئلة صح/خطأ + املأ الفراغات لتدريب إضافي.

Source: NCLEX & Prometric Exam Style Questions.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

42 — True/False + Fill Blanks | صح/خطأ + املأ الفراغات

✓ True or False / صح أم خطأ

1	**T/F:**Room number can be used as a patient identifier.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**رقم الغرفة يمكن استخدامه لتعريف المريض.**[خطأ]**
2	**T/F:**SBAR reduces critical events by 30%.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**SBAR يقلل الأحداث الحرجة بنسبة 30%.**[صح]**
3	**T/F:**Near-misses don't need incident reports.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**الحوادث الوشيكة لا تحتاج تقارير.**[خطأ]**
4	**T/F:**Time-Out must occur before ALL surgeries.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**Time-Out يجب أن يحدث قبل**كل**الجراحات.**[صح]**
5	**T/F:**Nurses should stay silent if they see errors.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**الممرضين يسكتوا لو شافوا أخطاء.**[خطأ]**
6	**T/F:**Braden Scale assesses pressure injury risk.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**مقياس Braden يقيم خطر قرح الفراش.**[صح]**
7	**T/F:**Restraints should be the FIRST option for agitation.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**التقييد يجب أن يكون الخيار**الأول**للهياج.**[خطأ]**
8	**T/F:**80% of medical errors are preventable.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**80% من الأخطاء الطبية يمكن منعها.**[صح]**

✏ Fill in the Blanks / املأ الفراغات

1. WHO has _____ Moments for Hand Hygiene. **(5)**	**1.** منظمة WHO لديها _____ لحظات لنظافة اليدين. **(5)**
2. There are _____ IPSG Goals. **(6)**	**2.** يوجد _____ أهداف IPSG. **(6)**
3. Doffing errors occur in _____% of workers. **(46)**	**3.** أخطاء الخلع تحدث في _____% من العاملين. **(46)**
4. Morse Score ≥ _____ = High fall risk. **(51)**	**4.** نتيجة Morse ≥ _____ = خطر سقوط عالي. **(51)**
5. The 5 Rights of medication start with Right _____. **(Patient)**	**5.** الحقوق الخمسة تبدأ بالحق _____. **(المريض)**
6. Turn bedridden patients every _____ hours. **(2)**	**6.** قلّب المرضى الممددين كل _____ ساعتين. **(2)**
7. Critical results reported within _____ minutes. **(30-60)**	**7.** النتائج الحرجة تُبلَّغ خلال _____ دقيقة. **(30-60)**
8. _____ Culture balances accountability & learning. **(Just)**	**8.** الثقافة _____ توازن بين المحاسبة والتعلم. **(العادلة)**

 Practice Daily: Cover the answers & test yourself. Repetition = mastery!

 تدرّب يومياً: غطي الإجابات واختبر نفسك. التكرار = الإتقان!

Source: Compiled from NCLEX & Prometric Exam Banks.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

⚡ Quick Review Cards / بطاقات مراجعة سريعة

🆔 IPSG 1
Rule: Use 2 identifiers
القاعدة: استخدم مُعرِّفين

🗣️ IPSG 2
SBAR: Situation, Background, Assessment, Recommendation
SBAR: موقف، خلفية، تقييم، توصية

💊 IPSG 3
High-Alert: Insulin, Heparin, KCl, Opioids
عالية الخطورة: إنسولين، هيبارين، KCl، مسكنات

✅ IPSG 4
Time-Out: Patient + Procedure + Site
Time-Out: مريض + إجراء + موضع

🧼 IPSG 5
Hand Hygiene: WHO 5 Moments
نظافة اليدين: 5 لحظات WHO

🚶 IPSG 6
Falls: Morse Scale ≥51 = High risk
السقوط: Morse ≥51 = خطر عالي

💉 5 RIGHTS
Patient, Drug, Dose, Route, Time
مريض، دواء، جرعة، طريق، وقت

🧀 Swiss Cheese
Reason: Holes align = Error reaches patient
Reason: الثقوب تتراص = الخطأ يوصل

🚫 Never Event
Serious preventable event that must NEVER happen
حدث خطير يجب **ألا يحدث**

🔍 Near Miss
Error caught BEFORE reaching patient
خطأ اكتُشف **قبل** وصوله للمريض

⚖️ Just Culture
Balance: Accountability + Learning
توازن: محاسبة + تعلم

🚨 RRT
HR<40 or >140, SBP<90, SpO2<90%
نبض <40 أو >140، ضغط <90

⚠️ KCl Rule
Concentrated KCl = Pharmacy ONLY!
KCl مركز = الصيدلية **فقط**!

🔄 Turn Q2H
Reposition every 2 hours to prevent pressure injury
قلّب كل ساعتين لمنع قرح الفراش

📊 3rd Cause
Medical errors = 3rd leading cause of death (USA)
الأخطاء الطبية = ثالث سبب للوفاة (أمريكا)

🗣️ CUS Tool
Concerned + Uncomfortable + Safety issue!
قلقان + مش مرتاح + مشكلة أمان!

💡 **How to Use:** Print, cut, review daily. Cover one side, recall the other!
💡 **طريقة الاستخدام:** اطبع، اقطع، راجع يومياً. غطي جانب واحد وتذكر الآخر!

Source: NurseHub Egypt Learning System.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

NCLEX / Prometric Tips / نصائح NCLEX وبروميتريك

Priority: Safety ALWAYS comes first!	**الأولوية:** السلامة دايماً أولاً!
2 Identifiers: ALWAYS the expected answer for patient ID	**مُعرِّفان:** دائماً الإجابة المتوقعة لتعريف المريض
SBAR: Standard framework for communication questions	**SBAR:** إطار قياسي لأسئلة التواصل
Speak Up: Nurses MUST report errors (choose this option!)	**اتكلم:** الممرضين **يجب** يبلغوا (اختر هذا الخيار!)

FAQ / أسئلة شائعة

Q1: What if I make a medication error?
A: Stop → Assess patient → Notify physician immediately → Document → Fill incident report. NEVER hide errors!

س1: لو عملت خطأ في الدواء؟
ج: توقف ← قيّم المريض ← بلّغ الطبيب فوراً ← وثّق ← املأ تقرير حادث. **ممنوع** إخفاء الأخطاء!

Q2: How often should I check high-risk patients?
A: Every 1-2 hours (or as ordered). ICU patients: every 15-30 minutes.

س2: كل قد إيه أفحص مرضى الخطر العالي؟
ج: كل 1-2 ساعة (أو حسب الأمر). مرضى ICU: كل 15-30 دقيقة.

Q3: Can I refuse to give a medication I think is unsafe?
A: YES! Your license depends on it. Question orders, verify with physician, document your concerns.

س3: هل أرفض إعطاء دواء أعتقد إنه غير آمن؟
ج: نعم! رخصتك تعتمد على هذا. اسأل عن الأوامر، تحقق من الطبيب، وثّق مخاوفك.

Q4: What if a doctor makes an error and refuses to fix it?
A: Follow chain of command: Charge Nurse → Nurse Manager → Medical Director → Patient Safety Officer.

س4: لو الطبيب عمل خطأ ورفض يصلحه؟
ج: اتبع سلسلة القيادة: ممرض مسؤول ← مدير التمريض ← مدير طبي ← مسؤول السلامة.

Q5: How do I document a patient's refusal of care?
A: Document the refusal, education provided, patient's understanding of risks, sign AMA form if needed.

س5: كيف أوثق رفض المريض للرعاية؟
ج: وثّق الرفض، التثقيف المقدم، فهم المريض للمخاطر، وقّع نموذج AMA إن لزم.

More Questions? Contact us via WhatsApp: 01095652098 — We're here to help!	**عندك أسئلة تانية؟** تواصل معنا واتساب: 01095652098 — احنا موجودين!

Source: NurseHub Egypt Community Q&A • NCLEX Prep Guides.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Top 10 Key Takeaways / أهم 10 نقاط

1	Patient Safety = Foundation of quality care	سلامة المريض = أساس الرعاية الجيدة
2	6 IPSG Goals are the "GPS" of nursing safety	أهداف IPSG الست هي "GPS" سلامة التمريض
3	Always use 2 identifiers (Name + DOB)	دائماً استخدم مُعرِّفين (اسم + تاريخ ميلاد)
4	SBAR = standardized communication tool	SBAR = أداة تواصل موحدة
5	5 Rights = Patient, Drug, Dose, Route, Time	5 حقوق = مريض، دواء، جرعة، طريق، وقت
6	80% of errors are PREVENTABLE with good systems	80% من الأخطاء يمكن منعها بأنظمة جيدة
7	Report all near-misses to prevent future errors	بلّغ الحوادث الوشيكة لمنع الأخطاء المستقبلية
8	Speak up! Silence kills patients	اتكلم! الصمت يقتل المرضى
9	Just Culture: Fix systems, not blame people	ثقافة عادلة: أصلح الأنظمة، مش تلوم الناس
10	"If not documented, it wasn't done!"	"لو ما اتوثقش، ما اتعملش!"

References (APA 7th Edition)

World Health Organization. (2021). **Global patient safety action plan 2021-2030: Towards eliminating avoidable harm in health care**. WHO Press. https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705

Joint Commission International. (2023). **Accreditation standards for hospitals (7th ed.)**. Joint Commission Resources.

Makary, M. A., & Daniel, M. (2016). **Medical error — the third leading cause of death in the US**. BMJ, 353, i2139. https://doi.org/10.1136/bmj.i2139

Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (Eds.). (1999). **To err is human: Building a safer health system**. National Academies Press.

Reason, J. (2000). **Human error: Models and management**. BMJ, 320(7237), 768-770. https://doi.org/10.1136/bmj.320.7237.768

Haynes, A. B., et al. (2009). **A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population**. NEJM, 360(5), 491-499.

Randmaa, M., Martensson, G., Swenne, C. L., & Engstrom, M. (2014). **SBAR improves communication**. Am J Med Quality, 29(5), 409-418.

Institute for Healthcare Improvement. (2023). **Framework for patient safety**. IHI Publications.

Agency for Healthcare Research and Quality. (2023). **Patient safety network (PSNet)**. AHRQ.gov.

Institute for Safe Medication Practices. (2023). **List of high-alert medications**. ISMP.org.

Marx, D. (2001). **Patient safety and the "just culture"**. Medical Event Reporting System.

National Pressure Injury Advisory Panel. (2019). **Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: Clinical practice guideline**. NPIAP.

Final Message: Master patient safety = Master nursing! Every action matters. Every patient counts.

الرسالة النهائية: اتقن سلامة المريض = اتقن التمريض! كل فعل مهم. كل مريض له قيمة.

Compiled by RN Ali Ashour, BSN ▪ NurseHub Egypt Editorial Team.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

THANK YOU FOR STUDYING WITH US!

THANK YOU!

شكراً لك

"First, do no harm. Every patient deserves safe, compassionate, and evidence-based care. YOU are the guardian of patient safety."

— RN Ali Ashour, BSN

CONGRATULATIONS!

You've completed the Patient Safety Master Guide! You're now equipped with world-class knowledge to protect your patients and yourself.

مبروك! لقد أكملت دليل سلامة المريض الشامل! أنت الآن مسلح بمعرفة عالمية المستوى لحماية مرضاك ونفسك.

GET IN TOUCH / تواصل معنا

Website:	nursehub-egypt.vercel.app
WhatsApp:	01095652098
Vodafone Cash:	01013489017
InstaPay:	wekaali321
Author:	RN, Ali Ashour, BSN

Get More Nursing Guides at NurseHub Egypt!